

# DOSSIÊ CIENTÍFICO DO AUTISMO

Estado da Arte, História, Evidências, Intervenções, Direitos e  
Perspectivas

**1911-2026 | Versão cumulativa para famílias, profissionais, educadores e pesquisadores**

**Objetivo: oferecer um acervo informativo baseado em evidências, distinguindo conhecimento consolidado, hipóteses, intervenções promissoras, incertezas científicas e práticas não recomendadas.**

Atualizado até 21 de setembro de 2026. Este material é educacional e não substitui avaliação médica, psicológica, fonoaudiológica, terapêutica ocupacional, nutricional, pedagógica ou jurídica individualizada.

Nota metodológica: o dossiê integra os levantamentos anteriores desta pesquisa e os amplia. Foram priorizadas fontes primárias, revisões sistemáticas, meta-análises, grandes estudos populacionais, diretrizes clínicas e órgãos oficiais como Organização Mundial da Saúde (OMS; WHO, World Health Organization), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American Academy of Pediatrics (AAP), National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Cochrane, PubMed/National Center for Biotechnology Information (NCBI), Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Portal do Planalto e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

## Como usar este dossiê

O documento foi desenhado em três camadas. A primeira explica o tema em linguagem acessível às famílias; a segunda descreve os fundamentos clínicos e científicos; a terceira remete a estudos e documentos-chave por meio de referências numeradas. As classificações de evidência usadas aqui são editoriais e não substituem sistemas formais como Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Todas as siglas, abreviações e símbolos técnicos empregados no material estão escritos por extenso e reunidos no Anexo F; no site, também possuem explicação contextual por toque ou passagem do cursor.

| Selo                                                                                                                    | Interpretação                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Consolidada/relativamente consistente | Convergência de diretrizes ou múltiplos estudos de boa qualidade para um objetivo específico.        |
|  Moderada/promissora                   | Há resultados favoráveis, porém com limitações relevantes ou efeitos pequenos/moderados.             |
|  Preliminar/inconsistente              | Resultados iniciais, heterogêneos ou insuficientes para rotina clínica.                              |
|  Experimental                          | Uso deve ficar restrito a pesquisa ou situações clínicas muito específicas, com forte justificativa. |
|  Não recomendada/perigosa              | Ausência consistente de benefício, diretriz contrária e/ou risco relevante.                          |
|  Dependente do objetivo                | A profissão ou modalidade é ampla; a evidência depende do problema funcional e da técnica utilizada. |

**Princípio transversal: uma intervenção deve tratar uma necessidade da pessoa, não a existência da pessoa.**

## Mapa do dossiê

| Seção      | Conteúdo                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Parte I    | História, definição, etiologia, diagnóstico, epidemiologia e conceitos centrais |
| Parte II   | Estudos fundamentais e bibliografia comentada                                   |
| Parte III  | Terapias, intervenções, reabilitação e medicamentos                             |
| Parte IV   | Tratamentos alternativos, experimentais, controversos e pseudociência           |
| Parte V    | Educação, escola inclusiva e participação                                       |
| Parte VI   | Adolescência, puberdade, sexualidade e transição                                |
| Parte VII  | Vida adulta, trabalho, moradia e envelhecimento                                 |
| Parte VIII | Família, cuidadores e rede de apoio                                             |
| Parte IX   | Meninas, mulheres, camuflagem e diagnóstico tardio                              |
| Parte X    | Altas necessidades de suporte e o debate sobre “autismo profundo”               |
| Parte XI   | Saúde integral, crises, segurança e prevenção                                   |
| Parte XII  | Brasil: SUS, saúde suplementar, educação e direitos                             |
| Parte XIII | Fatores associados e causalidade: como interpretar riscos                       |

| Seção     | Conteúdo                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Parte XIV | Como avaliar ciência, terapias e alegações de cura                                |
| Parte XV  | Mitos e fatos                                                                     |
| Parte XVI | Fronteiras científicas e agenda de pesquisa 2026+                                 |
| Anexos    | Checklists, roteiro pós-diagnóstico, passaporte de saúde, glossário e referências |

# PARTE I - HISTÓRIA E ESTADO ATUAL DO CONHECIMENTO

Da criação do termo à compreensão contemporânea de um espectro neurodesenvolvimental heterogêneo.

## 1. O que sabemos hoje

O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é compreendido atualmente como um conjunto diverso de condições relacionadas ao desenvolvimento do cérebro. As características centrais envolvem diferenças persistentes na comunicação e interação social e padrões restritos ou repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, incluindo aspectos sensoriais. As habilidades e necessidades variam amplamente e podem mudar ao longo da vida. A OMS estima que cerca de 1 em 127 pessoas no mundo tinha autismo em 2021. [R01]

Não existe um único “autismo”, uma causa única, um único perfil cognitivo ou uma trajetória universal. Algumas pessoas possuem deficiência intelectual e linguagem limitada; outras têm linguagem fluente e alta autonomia; muitas apresentam perfis mistos. O diagnóstico é fenotípico e clínico, e não a identificação de uma etiologia única.

A genética tem contribuição forte, mas complexa. Estudos populacionais e moleculares indicam participação de variantes comuns de pequeno efeito, variantes raras, alterações estruturais e mutações de novo. Herdabilidade elevada é uma medida populacional e não significa que uma porcentagem fixa do autismo de determinada pessoa “venha dos genes”. [R18-R21]

Até setembro de 2026, não existe exame de sangue, ressonância magnética, EEG, eye-tracking, inteligência artificial, microbioma ou painel genético capaz de diagnosticar TEA isoladamente. Essas ferramentas podem apoiar investigação etiológica, pesquisa ou diferenciais, mas o diagnóstico continua baseado na história do desenvolvimento, observação clínica e funcionamento. [R02,R03,R72-R75]

**Pais não causam autismo. Falta de afeto não causa autismo. Vacinas não causam autismo. As principais organizações de saúde e grandes estudos epidemiológicos não sustentam relação causal entre vacinação e TEA. [R01,R14]**

## 2. Linha do tempo histórica e científica

| Período                      | Marco                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Séculos XVIII-XIX            | Relatos históricos, como Hugh Blair e o menino de Aveyron, foram retrospectivamente comparados ao autismo. Não é possível fazer diagnóstico retrospectivo confiável; têm valor historiográfico. |
| 1911 - Eugen Bleuler         | Cria o termo <i>Autismus</i> no contexto da esquizofrenia. O significado era diferente do TEA atual: referia-se a afastamento da realidade e predominância do mundo interno.                    |
| 1925-1927 - Grunya Sukhareva | Publica descrições clínicas de meninos e depois meninas com traços notavelmente semelhantes ao espectro moderno, antecipando aspectos sociais, motores e sensoriais.                            |
| 1943 - Leo Kanner            | Descreve 11 crianças em “ <i>Autistic Disturbances of Affective Contact</i> ”, consolidando uma síndrome infantil reconhecível na psiquiatria ocidental.                                        |
| 1944 - Hans Asperger         | Publica sobre “ <i>psicopatia autística</i> ”. Décadas depois, documentos históricos revelariam envolvimento problemático com estruturas médicas da Viena nazista.                              |
| 1940s-1960s                  | Teorias psicogênicas e a ideia da “mãe geladeira” ganham influência. Posteriormente são rejeitadas por ausência de evidência e por seu dano às famílias.                                        |
| 1964 - Bernard Rimland       | Ajuda a deslocar a explicação do autismo para modelos biológicos/neurodesenvolvimentais e a contestar a culpabilização parental.                                                                |

| Período                            | Marco                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1966 - Victor Lotter               | Realiza um dos primeiros grandes estudos epidemiológicos populacionais de comportamentos autísticos.                                                                 |
| 1960s-1970s - Eric Schopler        | Desenvolvimento do TEACCH e valorização dos pais como parceiros, e não como causa do quadro.                                                                         |
| 1977 - Folstein & Rutter           | Estudo clássico com 21 pares de gêmeos oferece evidência decisiva de contribuição genética e de um fenótipo mais amplo.                                              |
| 1978 - Michael Rutter              | Refina critérios e ajuda a separar autismo de esquizofrenia infantil.                                                                                                |
| 1979 - Wing & Gould                | Estudo de Camberwell sustenta a ideia de continuum/espectro, ampliando a definição além da forma clássica de Kanner.                                                 |
| 1980 - DSM-III                     | Reconhece oficialmente “infantile autism” como diagnóstico próprio.                                                                                                  |
| 1981 - Lorna Wing                  | Populariza internacionalmente “síndrome de Asperger”.                                                                                                                |
| 1985 - Baron-Cohen, Leslie & Frith | Estudo influente sobre “teoria da mente”; importante, mas insuficiente como explicação total do TEA.                                                                 |
| 1987 - DSM-III-R e Lovaas          | Critérios se ampliam; intervenção comportamental intensiva ganha destaque, posteriormente cercada de debates metodológicos e éticos.                                 |
| 1989-2000                          | Desenvolvimento do ADOS, ADI-R e ADOS-G por Catherine Lord, Michael Rutter, Susan Risi e colaboradores.                                                              |
| 1994 - DSM-IV                      | Organiza transtornos invasivos do desenvolvimento em categorias, incluindo autismo, Asperger e PDD-NOS.                                                              |
| 1998-2010 - Wakefield/MMR          | Pequena série de casos é indevidamente associada a vacinas. O artigo é retratado em 2010; investigações e grandes estudos posteriores refutam causalidade.           |
| 2000s                              | Explosão de pesquisas em genética, neuroimagem, desenvolvimento precoce, linguagem, sensorialidade, epidemiologia e intervenção.                                     |
| 2010                               | Ensaio do ESDM e PACT fortalecem intervenções desenvolvimentais/naturalísticas e mediadas por cuidadores.                                                            |
| 2013 - DSM-5                       | Unifica autismo, Asperger e PDD-NOS em Autism Spectrum Disorder, com dois domínios centrais e especificadores.                                                       |
| 2019-2022                          | Grandes coortes e estudos de exoma/GWAS aprofundam a arquitetura genética; CID-11 entra em vigor.                                                                    |
| 2022 - Lancet Commission           | Propõe pesquisa e cuidado ao longo da vida, personalização, participação de pessoas autistas e maior foco em quem necessita suporte intenso. [R24]                   |
| 2023-2026                          | Expansão de multiômicas, organoides, EEG/fNIRS, eye-tracking, IA, genômica de precisão e pesquisa participativa. Nenhum biomarcador substitui o diagnóstico clínico. |

### 3. Etiologia: modelo multifatorial

A evidência contemporânea favorece um modelo multifatorial e neurodesenvolvimental. Genética é a contribuição mais consistente, mas fatores biológicos e ambientais pré-natais/perinatais podem modificar risco em nível populacional. Associação estatística não permite afirmar que determinada exposição “causou o autismo” de uma pessoa.

- Genética: variantes comuns, variantes raras, CNVs, mutações de novo, variantes herdadas e síndromes monogênicas/estruturais em uma parcela dos casos. [R18-R21]

- Fatores associados em diferentes estudos: idade parental mais elevada, prematuridade, baixo peso, diabetes materno, certas infecções/condições inflamatórias, algumas exposições ambientais e uso gestacional de valproato. A magnitude e a certeza variam muito. [R63-R68]
- Valproato na gestação é uma associação de particular relevância clínica e exige aconselhamento médico pré-concepcional/gestacional; nunca deve ser interrompido abruptamente sem supervisão.
- Paracetamol na gravidez: grandes análises com comparação entre irmãos enfraquecem associações observacionais; a OMS afirmou em 2025 não haver evidência conclusiva de causalidade.
- Vacinas, estilo parental, falta de amor, telas, glúten, caseína e “toxinas” genéricas não são causas estabelecidas do TEA.

#### 4. Neurobiologia: o que significa “cérebro autista”

Não existe uma única área cerebral responsável pelo autismo. Estudos em grupos identificam diferenças médias em desenvolvimento sináptico, regulação gênica, conectividade, processamento sensorial, excitação/inibição, atenção, linguagem e cognição social. A variabilidade entre pessoas é muito grande, e uma diferença média de grupo não é um marcador diagnóstico individual.

A genética ajuda a explicar essa diversidade: múltiplos mecanismos moleculares podem convergir para fenótipos parcialmente semelhantes. Assim, TEA é melhor compreendido como um resultado fenotípico comum a diferentes trajetórias biológicas e desenvolvimentais do que como uma doença molecular única.

#### 5. Diagnóstico em 2026

O diagnóstico integra história detalhada do desenvolvimento, observação direta, comunicação, linguagem, interação social, brincadeira, padrões repetitivos, interesses, sensorialidade, funcionamento adaptativo, contexto escolar e investigação de condições coexistentes. Instrumentos como ADOS-2, ADI-R e CARS-2 podem auxiliar; não “confirmam” TEA isoladamente.

A AAP mantém recomendação de vigilância do desenvolvimento e rastreamento específico para TEA aos 18 e 24 meses, com o relatório clínico de 2020 reafirmado em outubro de 2025. [R02] M-CHAT-R/F é instrumento de rastreamento: resultado positivo indica necessidade de avaliação adicional, não diagnóstico.

Meninas, mulheres, pessoas com boa linguagem, adultos e pessoas que usam camuflagem social podem ser reconhecidos mais tarde. Critérios históricos e instrumentos foram construídos em amostras predominantemente masculinas, o que contribui para subdiagnóstico ou diagnóstico tardio em alguns grupos. [R52-R55]

#### 6. Condições coexistentes e diagnóstico diferencial

O cuidado moderno evita atribuir tudo ao autismo. Deficiência intelectual, TDAH, epilepsia, ansiedade, depressão, alterações do sono, seletividade alimentar, condições gastrointestinais, dificuldades motoras, linguagem, audição/visão, dor, obesidade e problemas odontológicos podem coexistir. [R02]

Mudança súbita de comportamento ou perda de habilidades deve motivar avaliação clínica. Dor, constipação, refluxo, infecção, problemas dentários, privação de sono, epilepsia, efeitos de medicamentos, sobrecarga sensorial e alterações ambientais são exemplos de causas que podem se manifestar como irritabilidade ou crise.

#### 7. Prevalência: interpretar números corretamente

| Fonte/população                                        | Estimativa                     | Como interpretar                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMS, estimativa global para 2021                       | ~1 em 127 pessoas              | Estimativa global modelada; não equivalente a sistemas locais de vigilância. [R01]                                       |
| CDC ADDM, crianças de 8 anos em 16 áreas dos EUA, 2022 | 32,2/1.000, ~1 em 31           | Vigilância em áreas específicas; variação substancial entre comunidades. Não representa automaticamente o mundo inteiro. |
| Brasil, Censo 2022                                     | 2,4 milhões; 1,2% da população | Diagnóstico informado por morador e feito previamente por profissional; primeira medição censitária nacional. [R04]      |

| Fonte/população  | Estimativa                       | Como interpretar                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brasil, 5-9 anos | 2,6%; meninos 3,8%, meninas 1,3% | Mostra concentração de diagnósticos nas faixas infantis e diferença por sexo, não necessariamente diferença biológica total. [R04] |

Aumento da prevalência identificada não equivale automaticamente a “epidemia biológica”. Critérios mais amplos, reconhecimento de apresentações sutis, diagnóstico de pessoas sem deficiência intelectual, maior acesso, conscientização e mudanças de vigilância influenciam as séries temporais.

## 8. Neurodiversidade e modelo centrado na pessoa

O movimento da neurodiversidade chama atenção para variações neurológicas como parte da diversidade humana e critica metas de simples normalização. Uma abordagem clínica madura não precisa negar deficiência: é possível valorizar identidade e diferença ao mesmo tempo em que se tratam epilepsia, dor, ansiedade, autoagressão, comunicação limitada ou dependência funcional.

**Aceitação e suporte não são opostos. O objetivo é reduzir sofrimento, ampliar comunicação, segurança, participação, autonomia e qualidade de vida, sem pressupor que toda diferença precise ser eliminada.**

## PARTE II - ESTUDOS FUNDAMENTAIS E BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Como a evidência evoluiu e como ler os trabalhos que mudaram o campo.

### 9. Hierarquia prática de evidências

| Nível | Tipo                                                            | Uso típico                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A     | Revisões sistemáticas/meta-análises de estudos de boa qualidade | Síntese da melhor evidência disponível.                 |
| A/B   | Ensaio clínico randomizado                                      | Eficácia/segurança de intervenções.                     |
| B     | Grandes coortes populacionais                                   | Prevalência, fatores associados e trajetória.           |
| B     | Genômica de larga escala                                        | Arquitetura genética e mecanismos.                      |
| B/C   | Estudos longitudinais                                           | Desenvolvimento, prognóstico e persistência de efeitos. |
| C     | Caso-controle/transversal                                       | Associação e geração de hipóteses.                      |
| D     | Séries de casos                                                 | Sinal inicial; não prova eficácia/causa.                |
| E     | Relato individual/opinião                                       | Valor exploratório ou histórico; baixa força causal.    |

A classificação acima é simplificada. Qualidade metodológica importa dentro de cada tipo: uma meta-análise de estudos ruins não se transforma magicamente em evidência forte.

### 10. Estudos históricos comentados

| Estudo                                   | Desenho                              | Por que importa                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sukhareva, 1925-1927                     | Séries clínicas                      | Descrições precursoras de crianças, inclusive meninas, com aspectos sociais, motores e sensoriais semelhantes ao espectro moderno. Limitação: conceitos atuais não existiam. |
| Kanner, 1943                             | Série de 11 casos                    | Marco da síndrome infantil na literatura ocidental. Limitação: amostra pequena e contexto diagnóstico histórico.                                                             |
| Folstein & Rutter, 1977                  | 21 pares de gêmeos                   | Evidência pioneira de forte contribuição genética e fenótipo ampliado. Importante historicamente; números não devem ser usados como estimativas modernas isoladas.           |
| Wing & Gould, 1979                       | Epidemiológico                       | Sustentou continuum/espectro e mostrou apresentações além do autismo clássico.                                                                                               |
| Lovaas, 1987                             | Intervenção comportamental histórica | Influenciou EIBI/ABA. Limitações metodológicas, critérios antigos e linguagem de “normalização” exigem leitura crítica.                                                      |
| Dawson/Rogers et al., 2010               | RCT ESDM, 48 crianças                | Ganhos em cognição/comportamento adaptativo em média; replicações posteriores mostram variabilidade.                                                                         |
| Green et al., 2010; Pickles et al., 2016 | RCT e follow-up PACT                 | Intervenção mediada por cuidadores; efeitos persistentes em algumas medidas de interação/comunicação.                                                                        |
| Bai et al., 2019                         | Coorte multinacional >2 milhões      | Herdabilidade mediana ~80,8%; reforça                                                                                                                                        |

| Estudo                            | Desenho                             | Por que importa                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                     | contribuição genética populacional.                                                                                             |
| Satterstrom et al., 2020          | Exoma em 35.584 indivíduos          | 102 genes de risco no critério usado; mostra heterogeneidade e vias de regulação gênica/comunicação neuronal.                   |
| Fu et al., 2022                   | Sequenciamento em 63.237 indivíduos | 72 genes em limiar rigoroso e 185 em limiar mais amplo; integra variantes raras e outros tipos de alteração.                    |
| Sandbank et al./Project AIM, 2023 | Meta-análise ampla                  | 252 estudos, 13.304 participantes, 3.291 resultados; mostrou benefícios específicos e impacto do risco de viés nas estimativas. |

## 11. Genética clínica: do risco populacional ao paciente

A genética do TEA combina variantes comuns de pequeno efeito e variantes raras/estruturais de maior efeito. Em uma parcela dos indivíduos, o TEA aparece dentro de síndromes ou condições genéticas reconhecíveis, como X frágil, esclerose tuberosa, Phelan-McDermid/SHANK3, variantes em CHD8, SCN2A, ADNP, FOXP1, SYNGAP1, PTEN, MECP2 e CNVs como 16p11.2.

Avaliação genética pode ser especialmente relevante quando há deficiência intelectual, epilepsia, malformações, alterações de crescimento, características dismórficas, regressão incomum ou história familiar sugestiva. A AAP recomenda considerar avaliação genética, microarray e X frágil, e, em contextos apropriados, sequenciamento de exoma. Um teste negativo não exclui TEA. [R02]

## 12. Como registrar um artigo no acervo

| Campo                 | O que registrar                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação         | Autores, ano, título, periódico, DOI, PMID/registro.                           |
| Pergunta              | O que o estudo realmente tentou responder?                                     |
| Desenho               | RCT, coorte, caso-controle, meta-análise, genética, qualitativo etc.           |
| Amostra               | Número de participantes, idade, sexo, país, critérios de inclusão.             |
| Intervenção/exposição | Dose, duração, intensidade, comparador.                                        |
| Desfecho              | O que foi medido e por quem? É clínico, funcional ou apenas escore?            |
| Resultado             | Tamanho de efeito/risco absoluto quando disponível, não apenas “ $p < 0,05$ ”. |
| Risco de viés         | Cegamento, randomização, perda de seguimento, seletividade de desfechos.       |
| Limitações            | Generalização, tamanho da amostra, duração, conflitos, replicação.             |
| Aplicação             | O que uma família/profissional pode concluir - e o que não pode.               |
| Status                | Ativo, corrigido, retratado ou substituído por evidência mais recente.         |

## PARTE III - TERAPIAS, INTERVENÇÕES, REABILITAÇÃO E MEDICAMENTOS

O que cada abordagem pretende fazer, para quem, com quais evidências e limitações.

### 13. Regra básica: evidência é específica do objetivo

Nenhuma intervenção não farmacológica demonstrou benefício uniforme para todos os desfechos relevantes. Dizer que uma terapia “tem evidência” sem definir o alvo é impreciso. Uma intervenção pode ter boa evidência para atenção conjunta e pouca para linguagem; um medicamento pode reduzir irritabilidade sem afetar características centrais do TEA.

A atualização do Project AIM mostrou que vários efeitos diminuem quando são removidos resultados com maior risco de viés, informantes não cegos ou medidas muito próximas ao comportamento treinado. Isso não significa que as intervenções sejam inúteis; significa que estimativas de eficácia devem ser interpretadas com rigor. [R31]

### 14. ABA e EIBI

Applied Behavior Analysis (ABA) é uma disciplina de análise do comportamento, não um protocolo único. Pode incluir análise funcional, reforçamento, ensino por tentativas discretas, ensino incidental, treino de comunicação funcional, prompting/fading, generalização e estratégias naturalísticas. EIBI refere-se à aplicação intensiva e precoce de princípios comportamentais.

Revisões modernas indicam possíveis benefícios para habilidades específicas, linguagem, comportamento adaptativo ou cognição em alguns grupos, mas a certeza global varia e muitos estudos possuem risco de viés. O estudo clássico de Lovaas não prova “cura” nem deve ser transposto integralmente à prática atual.

A ética contemporânea exige metas funcionalmente importantes, assentimento quando possível, respeito à comunicação e aos comportamentos autorregulatórios seguros. Suprimir stimming inofensivo ou impor contato visual por aparência social é uma justificativa diferente de ensinar comunicação de dor, segurança no trânsito ou substituição de autoagressão.

**Pergunta correta: “qual procedimento, para qual comportamento, com qual medida de resultado?” - e não apenas “ABA funciona?”.**

### 15. NDBI, ESDM, PRT, JASPER e PACT

| Abordagem | Foco                                                                               | Síntese da evidência                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDBI      | Aprendizagem naturalística combinando desenvolvimento e princípios comportamentais | Meta-análises encontram efeitos pequenos a moderados em comunicação, linguagem, brincadeira e engajamento; qualidade e desfecho importam. ● |
| ESDM      | Intervenção precoce naturalística, desenvolvimento, brincadeira e interação        | Ensaio inicial mostrou ganhos; resultados posteriores são variáveis. ●                                                                      |
| PRT       | Motivação, iniciativa, responsividade e comunicação                                | Revisões sugerem benefícios sobretudo para linguagem/comunicação; outros desfechos menos consistentes. ●                                    |
| JASPER    | Atenção conjunta, brincadeira simbólica, engajamento e regulação                   | Resultados favoráveis principalmente em habilidades proximais de atenção conjunta/brincadeira; generalização requer mais evidência. ●       |
| PACT      | Comunicação social mediada pelo cuidador                                           | RCT e seguimento de longo prazo mostram efeitos em interação/comunicação e algumas medidas autísticas. ●                                    |

## 16. TEACCH, PECS e CAA/AAC

TEACCH utiliza ensino estruturado, organização visual, previsibilidade, ambiente físico e rotinas para apoiar aprendizagem e independência. Meta-análises recentes sugerem efeitos em comunicação, habilidades de vida diária, motricidade e habilidades sociais, porém com heterogeneidade. ●

PECS é um protocolo específico de comunicação por troca de figuras; não é sinônimo de CAA. Pode melhorar comunicação funcional, mas o efeito sobre fala oral é menor e inconsistente. O sucesso deve ser medido pela capacidade de comunicar necessidades e ideias, não apenas pelo aparecimento de fala.

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA/AAC) inclui gestos, sinais, fotografias, símbolos, pranchas, escrita, dispositivos geradores de voz, aplicativos e rastreamento ocular. Evidência não justifica retirar CAA para “forçar a fala”; em alguns estudos, integrar AAC a intervenções naturalísticas melhora resultados de linguagem. ●/●

## 17. Fonoaudiologia, terapia ocupacional e sensorialidade

Fonoaudiologia pode tratar linguagem receptiva/expressiva, pragmática, comunicação social, apraxia/motricidade da fala, CAA e alimentação/deglutição quando indicado. Não existe uma única “fono para autismo”; a evidência depende do déficit e do método. ●/●

Terapia ocupacional pode trabalhar autocuidado, alimentação, vestir-se, brincar, escrita, participação escolar, coordenação, planejamento motor, adaptações ambientais e sensorialidade relacionada a ocupações. Também não é sinônimo de “terapia sensorial”. ●

Ayres Sensory Integration (ASI), quando aplicada com fidelidade, possui evidência crescente para metas ocupacionais individualizadas em algumas crianças, mas não é tratamento global do TEA nem justificativa para qualquer atividade sensorial genérica. ●

## 18. TCC, DIR/Floortime, musicoterapia, equoterapia e habilidades sociais

| Intervenção                     | Uso mais defensável                                                                                          | Evidência                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCC adaptada                    | Ansiedade e outros sintomas emocionais em pessoas capazes de participar; requer adaptações visuais/concretas | ●/●                                                                                                         |
| DIR/Floortime                   | Interação, desenvolvimento emocional e relacionamento                                                        | ●/●; base menor e mais heterogênea                                                                          |
| Musicoterapia                   | Objetivos complementares, engajamento e qualidade de vida                                                    | ●; Cochrane encontra alguns efeitos, mas comunicação verbal/social específica não é consistentemente melhor |
| Equoterapia/hipoterapia         | Objetivos motores, participação e alguns comportamentos                                                      | ●/●; protocolos heterogêneos                                                                                |
| Treino de habilidades sociais   | Conhecimento e habilidades sociais específicas, sobretudo em jovens verbais                                  | ●; generalização para vida cotidiana é um desafio                                                           |
| Intervenções mediadas por pares | Participação social em ambientes naturais, principalmente escola                                             | ●; úteis quando o ambiente também é modificado                                                              |

## 19. Medicamentos: tratar alvo, não o rótulo

Não há medicamento aprovado para “curar” TEA ou tratar de maneira abrangente suas características centrais. Fármacos podem ser importantes para sintomas-alvo e condições coexistentes.

| Classe/fármaco | Possível alvo                                       | Pontos de atenção                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risperidona    | Irritabilidade/agressividade grave em alguns jovens | Pode reduzir irritabilidade; monitorar peso, metabolismo, prolactina, sedação e sintomas motores. ●/● |

| Classe/fármaco                            | Possível alvo                      | Pontos de atenção                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aripiprazol                               | Irritabilidade/agressividade grave | Evidência de curto prazo; monitorar ganho de peso, sedação e sintomas extrapiramidais. ●/●                     |
| Metilfenidato/atomoxetina/guanfacina etc. | TDAH associado                     | Podem reduzir sintomas de TDAH; resposta/tolerabilidade variam. Tratar TDAH, não “autismo”.                    |
| Melatonina                                | Insônia em casos selecionados      | Meta-análises mostram melhora de latência/tempo total de sono; investigar causas de sono antes. ●/●            |
| Antiepiléticos                            | Epilepsia documentada              | Tratam epilepsia; anticonvulsivantes não devem ser usados para “características centrais” sem outra indicação. |

NICE recomenda definir comportamento-alvo, iniciar antipsicóticos com menor dose efetiva, revisar resposta e efeitos adversos precocemente e suspender quando não houver benefício clinicamente relevante. [R06]

## 20. Como escolher e monitorar uma intervenção

- Qual necessidade concreta estamos tentando melhorar?
- Esse comportamento causa sofrimento/risco ou apenas parece diferente?
- Qual é a linha de base mensurável?
- Qual desfecho indicará sucesso?
- Há evidência para esta abordagem nesse objetivo e faixa etária?
- O profissional possui formação, supervisão e limites de competência claros?
- A pessoa tolera e, quando possível, assente à intervenção?
- Os ganhos aparecem fora da sala de terapia?
- A intervenção aumenta autonomia ou cria dependência?
- Eventos adversos e fadiga estão sendo monitorados?
- O número de horas está equilibrado com escola, sono, brincar, lazer e vida familiar?
- O custo e a intensidade são proporcionais ao benefício observado?

Resultados proximais são aqueles muito parecidos com a habilidade treinada. Resultados distais mostram generalização para outros contextos e são mais difíceis de obter. Um programa pode ensinar “a resposta certa” em sessão sem que isso se converta automaticamente em amizade, participação escolar ou autonomia.

**Horas de terapia não são um desfecho. Comunicação, autonomia, participação, saúde, segurança, aprendizagem, relações e qualidade de vida são desfechos.**

## PARTE IV - TRATAMENTOS ALTERNATIVOS, EXPERIMENTAIS, CONTROVERSOS E PSEUDOCIÊNCIA

Separando pesquisa legítima em andamento de promessas comerciais e práticas potencialmente perigosas.

### 21. Por que esta parte é essencial

Famílias frequentemente chegam ao diagnóstico em situação de incerteza e vulnerabilidade. Isso cria um mercado fértil para tratamentos apresentados como “naturais”, “biomédicos”, “detox”, “reversão”, “recuperação” ou “cura”. Alguns desses temas são pesquisa científica legítima ainda imatura; outros foram testados e não funcionaram; alguns podem provocar dano grave.

A classificação abaixo considera qualidade da evidência, consistência, plausibilidade, replicação, eventos adversos e posicionamento de diretrizes. Ela não substitui decisão clínica individual.

### 22. Microbioma, probióticos, prebióticos e transplante fecal

O eixo intestino-cérebro é uma área científica legítima. Pessoas autistas podem apresentar maior frequência de sintomas gastrointestinais e padrões dietéticos particulares, e estudos encontram diferenças médias na microbiota. A dificuldade é separar causa de consequência: seletividade alimentar, constipação, medicamentos, antibióticos, idade e dieta também alteram o microbioma.

Meta-análise de 2025 de 15 RCTs encontrou efeito agregado pequeno de intervenções direcionadas à microbiota (SMD aproximado de -0,12). Revisões de transplante de microbiota fecal incluem poucos ensaios randomizados e vários estudos antes/depois, com grande heterogeneidade. [R37,R38]

**Classificação: probióticos/prebióticos/FMT para tratar características centrais do TEA = 🟡/🟠.**

**Tratar constipação, diarreia ou outra condição gastrointestinal diagnosticada é uma questão clínica diferente.**

### 23. Canabidiol, cannabis e derivados

Cannabinoides têm sido investigados para ansiedade, irritabilidade, sono e comportamento. Uma revisão sistemática de 2025 com sete estudos e 494 participantes encontrou resultados modestos e inconsistentes. Outra revisão de ensaios randomizados concluiu que a certeza das evidências era baixa ou muito baixa, com diferentes formulações, proporções CBD:THC, doses e desfechos. [R39,R40]

Além da incerteza de eficácia, existem questões de interação medicamentosa, sedação, efeitos gastrointestinais, qualidade do produto e exposição a THC. A existência de estudos promissores não equivale a indicação universal.

**Classificação: 🟡 experimental para alvos específicos; não é tratamento estabelecido das características centrais do TEA.**

### 24. Dietas: sem glúten/caseína, cetogênica e outras restrições

Dietas de exclusão continuam populares, mas diretrizes como NICE não recomendam dieta sem glúten/caseína nem dieta cetogênica para manejo das características centrais do TEA. Estudos e meta-análises encontram resultados mistos, amostras pequenas e heterogêneas. [R06,R07]

Restrição alimentar pode ser apropriada quando existe doença celíaca, alergia, intolerância, epilepsia com indicação específica de dieta cetogênica ou outra condição médica. Isso é diferente de usar dieta como “tratamento do autismo”. Em crianças seletivas, dietas adicionais podem aumentar risco de deficiência nutricional.

**Classificação: dieta restritiva para características centrais = 🟡/🔴 como rotina. Dieta terapêutica para doença diagnosticada = decisão médica/nutricional específica.**

## 25. Vitaminas, minerais, ômega-3 e suplementos

Baixos níveis de determinados nutrientes podem ocorrer em pessoas autistas, principalmente diante de seletividade alimentar. Deficiência comprovada deve ser corrigida. Isso não significa que doses altas em pessoas sem deficiência tratem TEA.

| Produto                   | Estado da evidência                                                                                                                                                                      | Classificação                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vitamina D                | Alguns RCTs/meta-análises mostram sinais pequenos em determinados escores; revisões críticas de 2026 não sustentam uso geral direcionado ao TEA. Corrigir deficiência continua indicado. | ● para TEA; ● para deficiência |
| Vitamina B6 + magnésio    | Cochrane encontrou apenas poucos ensaios pequenos, evidência insuficiente.                                                                                                               | ●/● para uso rotineiro         |
| Ômega-3                   | Meta-análises mostram resultados inconsistentes e pequenos em subgrupos; NICE não recomenda para problemas de sono em jovens autistas.                                                   | ●                              |
| Multivitamínicos/minerais | Pode haver indicação nutricional individual; “megadoses” sem deficiência não possuem base robusta para TEA.                                                                              | ●/●                            |
| N-acetilcisteína - NAC    | Pequenos RCTs sugerem possíveis efeitos de curto prazo em alguns comportamentos; base ainda limitada.                                                                                    | ●                              |

## 26. Ácido folínico/leucovorina

Há interesse particular em ácido folínico, especialmente em subgrupos com alterações relacionadas ao transporte de folato. Um pequeno RCT de 2016 com 48 crianças com TEA e prejuízo de linguagem relatou melhora de comunicação verbal, com sinal maior em participantes positivos para autoanticorpos do receptor de folato alfa. [R41]

Entretanto, um ensaio randomizado publicado em 2024, frequentemente citado como evidência adicional, foi formalmente RETRATADO em 29 de janeiro de 2026. A retratação precisa acompanhar qualquer revisão atual da literatura para que resultados inválidos não continuem circulando. [R42]

Autoanticorpos do receptor de folato e cerebral folate deficiency são temas especializados; testes comerciais e prescrição não devem ser tratados como protocolo universal para TEA.

**Classificação:** ● - hipótese/subgrupo promissor, mas evidência insuficiente para uso universal. Não utilizar o ensaio retratado de 2024 como suporte.

## 27. Sulforafano

Sulforafano, composto encontrado em vegetais crucíferos, é investigado por mecanismos antioxidantes e celulares. Meta-análises de 2025 reuniram seis RCTs (uma análise reportou 333 participantes) e encontraram efeitos pequenos em alguns escores de comportamento/socialização, mas não em todos os domínios, com limitações de duração, avaliadores e heterogeneidade. [R43,R44]

**Classificação:** ●. Promissor como linha de pesquisa, não tratamento estabelecido.

## 28. Bumetanida

A bumetanida é um diurético de alça estudado experimentalmente por hipóteses envolvendo transporte de cloro neuronal e sinalização GABAérgica. Uma meta-análise publicada em 2026 reuniu nove estudos (sete RCTs e dois observacionais), 952 crianças/adolescentes, encontrando redução de curto prazo em CARS, mas alta heterogeneidade e ausência de diferença significativa em seguimento de seis meses. A certeza global foi baixa ou muito baixa. [R45]

A droga aumenta riscos de hipocalcemia, poliúria, diurese e desidratação, o que é especialmente relevante porque não se trata de suplemento inofensivo.

**Classificação:** 🟡 experimental. Não é tratamento padrão do TEA.

## 29. Oxitocina intranasal

A oxitocina foi estudada por sua participação em processos sociais. Meta-análises recentes encontram, no máximo, sinais pequenos e inconsistentes, com heterogeneidade de dose, idade e instrumentos. NICE recomenda não usar oxitocina para características centrais em adultos. [R07]

**Classificação:** 🟡/🔴. Pesquisa em andamento, sem base para rotina clínica.

## 30. Neurofeedback, tDCS/TMS e outras neuromodulações

Neurofeedback e estimulação transcraniana são áreas de pesquisa. Estudos pequenos e meta-análises recentes de tDCS reportam sinais em alguns desfechos, porém amostras são pequenas, protocolos variam e validação independente é limitada. NICE recomenda não usar neurofeedback para problemas de fala e linguagem em crianças e jovens autistas. [R06]

**Classificação:** 🟡 para tratamento de TEA fora de pesquisa; não confundir evidência experimental com padrão assistencial.

## 31. Células-tronco, exossomos e “medicina regenerativa”

Ensaio experimentais de células-tronco foram publicados, mas não há demonstração suficiente de eficácia e segurança para uso clínico rotineiro no TEA. A FDA alerta que produtos de células-tronco e exossomos não são aprovados para tratar autismo e que clínicas podem comercializar produtos sem comprovação, inclusive com riscos relevantes. [R46]

**Classificação:** 🟡/🔴 fora de ensaio clínico regulado. “Tratamento com células-tronco para autismo” vendido comercialmente não deve ser confundido com pesquisa aprovada.

## 32. Secretina

Secretina tornou-se popular após relatos anedóticos no final da década de 1990. A revisão Cochrane atualizada reuniu 16 ensaios randomizados controlados por placebo, envolvendo mais de 900 crianças, e não encontrou benefício para características centrais, comunicação ou comportamento. [R47]

**Classificação:** 🔴. Não recomendada.

## 33. Quelantes e “metais pesados”

A hipótese de que o TEA seria causado por “metais pesados acumulados” levou ao uso indevido de quelantes. A Cochrane não encontrou evidência clínica que justificasse quelação para TEA e alertou para riscos. [R48]

O risco não é teórico: o CDC documentou a morte de um menino autista de 5 anos em 2005 durante quelação intravenosa com Na2EDTA, associada a hipocalcemia grave. [R49]

**Classificação:** 🔴. Não recomendada para TEA e potencialmente fatal. Envenenamento real por metal é outra situação médica, com diagnóstico e protocolo toxicológico específicos.

## 34. Oxigenoterapia hiperbárica

Pequenos estudos e algumas revisões encontraram sinais favoráveis, mas ensaios com controle simulado e revisões de maior rigor não demonstraram benefício convincente. A Cochrane identificou evidência insuficiente e NICE recomenda não usar oxigenoterapia hiperbárica para manejar autismo. [R06]

**Classificação:** 🔴 para uso rotineiro em TEA; pesquisa positiva de baixa qualidade não supera ausência de benefício robusto e diretrizes contrárias.

### 35. MMS, dióxido de cloro, “detox”, antiparasitários e protocolos secretos

MMS/“Miracle Mineral Solution” produz dióxido de cloro, substância oxidante semelhante a alvejante industrial. A FDA registrou relatos de vômitos intensos, diarreia, hipotensão grave e insuficiência hepática e atuou contra vendedores que o anunciavam como cura para autismo e outras doenças. [R50]

“Detox”, enemas corrosivos, protocolos de parasitas sem diagnóstico, doses farmacológicas de suplementos ou misturas secretas devem ser tratados como sinais de alerta. “Natural” não significa seguro, e a linguagem “a medicina não quer que você saiba” é estratégia de marketing, não evidência.

**Classificação:** . **Potencialmente perigoso. Qualquer suspeita de intoxicação ou evento adverso exige atendimento médico.**

### 36. Matriz resumida de intervenções controversas

| Abordagem                      | Situação em 2026                                                                      | Selo                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microbioma/probióticos         | Pesquisa ativa; efeito médio pequeno, heterogeneidade e forte influência de dieta/GI. |                                                                                            |
| FMT                            | Poucos ensaios; protocolos não padronizados.                                          |                                                                                            |
| CBD/cannabis                   | Alguns sinais, certeza baixa/muito baixa, formulações variáveis.                      |                                                                                            |
| GFCF/cetogênica para “autismo” | Evidência inconsistente; diretrizes não recomendam para características centrais.     |  /      |
| Vitamina D/ômega-3/NAC         | Possíveis sinais pequenos; corrigir deficiência quando existente.                     |                                                                                            |
| Folinato/leucovorina           | Possível subgrupo; um RCT importante foi retratado em 2026.                           |                                                                                          |
| Sulforafano                    | Meta-análises pequenas mostram efeitos modestos.                                      |                                                                                          |
| Bumetanida                     | Sinal de curto prazo + riscos eletrolíticos/diurese; certeza baixa.                   |                                                                                          |
| Oxitocina                      | Inconsistente.                                                                        |  /  |
| tDCS/TMS/neurofeedback         | Experimental, protocolos heterogêneos.                                                |                                                                                          |
| Células-tronco/exossomos       | Sem aprovação para autismo; risco de clínicas não reguladas.                          |  /  |
| Secretina                      | 16 RCTs sem benefício.                                                                |                                                                                          |
| Quelação                       | Sem benefício e risco grave.                                                          |                                                                                          |
| Oxigênio hiperbárico           | Sem evidência robusta; diretrizes contrárias.                                         |                                                                                          |
| MMS/dióxido de cloro           | Tóxico e sem benefício.                                                               |                                                                                          |

## PARTE V - EDUCAÇÃO, ESCOLA INCLUSIVA E PARTICIPAÇÃO

Da matrícula à participação real: ambiente, comunicação, aprendizagem e pertencimento.

### 37. Inclusão não é apenas estar na mesma sala

A literatura escolar mostra que aumentar acesso físico a atividades não garante reciprocidade, amizade ou participação significativa. Uma revisão de 56 estudos de intervenções em escolas comuns encontrou maior acessibilidade, mas amizade/reciprocidade nem sempre melhoraram; os autores defendem estratégias que modifiquem também colegas, equipe e ambiente. [R56]

O foco exclusivo em “consertar habilidades sociais da criança” pode falhar quando o problema envolve ruído, imprevisibilidade, bullying, material inacessível, comunicação insuficiente, atitudes de colegas ou falta de formação docente.

### 38. Componentes de um plano educacional funcional

- Perfil de comunicação: fala, CAA, compreensão, tempo de processamento e forma de pedir ajuda.
- Perfil sensorial e ambiental: ruído, iluminação, aglomeração, transições, recreio e alimentação.
- Acesso curricular: como apresentar instruções, avaliar aprendizagem e oferecer apoios visuais.
- Funções executivas: agenda visual, fragmentação de tarefas, antecipação de mudanças e organização.
- Participação social: apoio de pares, prevenção de isolamento e oportunidades naturais de interação.
- Autonomia: banheiro, alimentação, deslocamento, materiais e autocuidado conforme idade.
- Plano de prevenção e manejo de crises baseado em gatilhos e sinais precoces, não punição.
- Saúde e segurança: epilepsia, alergias, medicações, fuga/elopement e contatos de emergência.
- Plano de transição entre etapas escolares e para a vida pós-escola.

### 39. Intervenções escolares com melhor lógica de generalização

Intervenções mediadas por pares, apoios visuais, autorregulação/automonitoramento, ensino funcional e estratégias implementadas pelo professor podem produzir benefícios em ambientes inclusivos, embora a base ainda seja desigual. Revisões recentes mostram que peer-mediated interventions podem ser eficazes, mas acompanhamento de longo prazo é raro. [R57,R58]

A generalização tende a ser maior quando a habilidade é ensinada no local em que será usada: pedir ajuda na sala de aula, negociar brincadeira no recreio, utilizar CAA no refeitório ou organizar materiais na própria rotina escolar.

### 40. Bullying, vitimização e ausência escolar

Pessoas autistas têm risco elevado de diferentes formas de vitimização, com alta heterogeneidade entre estudos. Uma meta-análise encontrou prevalência agregada de vitimização de 44%, reforçando a necessidade de prevenção, canais de denúncia acessíveis e educação de colegas/profissionais. [R59]

Uma revisão de 42 estudos sobre ausência escolar mostrou risco de faltas maior em estudantes autistas, frequentemente associado a saúde mental, outras condições neurodesenvolvimentais, bullying e baixa compreensão do autismo na escola. [R60]

**Recusa/ausência escolar deve ser investigada como sinal: ansiedade, bullying, sobrecarga sensorial, demandas incompatíveis, sono, transporte, dor ou falha de suporte podem estar envolvidos.**

### 41. AEE no Brasil

O INEP define o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como atividade pedagógica complementar à escolarização de estudantes com deficiência e TEA e suplementar para altas habilidades/superdotação. Deve constar no Projeto Político-Pedagógico e ser garantido em todas as etapas e modalidades da educação básica, com foco em eliminar barreiras ao acesso, permanência, participação e aprendizagem. A página oficial foi atualizada em 31 de agosto de 2026. [R61]

AEE não substitui matrícula nem escolarização na classe comum. Seu papel é organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade necessários à participação.

## PARTE VI - ADOLESCÊNCIA, PUBERDADE, SEXUALIDADE E TRANSIÇÃO

O cuidado precisa antecipar mudanças biológicas, sociais e funcionais antes que virem crise.

### 42. Puberdade e desenvolvimento

Puberdade pode aumentar demandas sociais e sensoriais. Mudanças corporais, higiene, odor, pelos, acne, menstruação, ereções, masturbação, privacidade e novas expectativas sociais precisam ser ensinadas de forma explícita, concreta e adequada ao nível de compreensão. Não se deve presumir que a pessoa aprenderá essas regras apenas observando os pares.

Para jovens com deficiência intelectual ou comunicação limitada, materiais visuais, histórias sociais, CAA e rotinas passo a passo podem ser úteis. O conteúdo deve enfatizar autonomia corporal, consentimento, espaços públicos/privados e como pedir ajuda.

### 43. Sexualidade não desaparece no autismo

Revisão sistemática de 2025 concluiu que pessoas autistas apresentam desejos e interesses sexuais comparáveis aos de outras pessoas, mas podem enfrentar barreiras de comunicação, sensibilidades sensoriais, dificuldades de relacionamento e maior risco de vitimização. [R62]

Educação sexual protetiva inclui nomes corretos das partes do corpo, consentimento, limites, reconhecimento de manipulação, segurança digital, contracepção quando pertinente, prevenção de ISTs, orientação sobre relacionamentos e caminhos para relatar abuso.

### 44. Transição para a vida adulta

Planejamento deve começar antes do último ano escolar. Revisão sistemática de 2025 sobre transição pós-ensino médio mostrou resultados ainda insatisfatórios e limitações nos preparativos atuais. [R63]

- Documentação e benefícios/direitos
- Habilidades de vida diária
- Deslocamento e transporte
- Formação profissional/emprego
- Uso de dinheiro e decisões
- Saúde: transição da pediatria para serviços de adultos
- Moradia e rede de apoio
- Relacionamentos e sexualidade
- Comunicação em emergências
- Planejamento financeiro e futuro após incapacidade/morte dos cuidadores

## PARTE VII - VIDA ADULTA, TRABALHO, MORADIA E ENVELHECIMENTO

Autismo é uma condição ao longo da vida; a pesquisa adulta ainda é desproporcionalmente pequena.

### 45. Adultos: lacuna histórica

Durante décadas, a maior parte da pesquisa focou crianças. Adultos enfrentam barreiras no acesso à saúde, diagnóstico tardio, saúde mental, emprego, educação pós-secundária, relações, moradia e serviços. A literatura recente começa a corrigir essa lacuna, mas ainda há menos ensaios e menos dados longitudinais do que em pediatria.

### 46. Intervenções em adultos

Meta-análise de 2026 incluiu 35 estudos e 1.631 participantes. Foram observados efeitos pequenos a moderados em saúde mental ( $g \approx 0,35$ ), cognição social ( $g \approx 0,45$ ) e qualidade de vida ( $g \approx 0,64$ ); efeitos agregados em comportamento adaptativo e emprego não foram significativos. [R64]

Isso reforça que suporte adulto não pode ser mera continuação de programas infantis. As metas precisam incluir vida independente, saúde mental, relacionamentos, trabalho, organização cotidiana e participação comunitária.

### 47. Emprego apoiado

NICE recomenda programas individualizados de emprego apoiado que incluam preparação de currículo e entrevistas, treinamento no papel de trabalho, combinação cuidadosa entre pessoa e função, adaptações razoáveis e suporte ao empregado e ao empregador após a contratação. [R07]

Revisões de treinamento vocacional mostram crescimento de tecnologias de entrevista, treinamento de habilidades e modelos como Project SEARCH, mas estudos com emprego sustentado como desfecho real ainda são relativamente poucos.

### 48. Saúde de adultos e barreiras de acesso

Barreiras comuns incluem ambientes sensorialmente hostis, comunicação rápida ou ambígua, falta de conhecimento dos profissionais, dificuldade em descrever dor e ausência de adaptações. Estratégias simples - consulta mais previsível, instruções por escrito, tempo adicional, acompanhante escolhido e redução de estímulos - podem mudar a experiência assistencial.

### 49. Envelhecimento

Revisão sistemática publicada em 2026 destaca que trajetórias de envelhecimento cognitivo, neural e físico continuam pouco compreendidas. Não há evidência suficiente para afirmar que exista “envelhecimento globalmente acelerado” em todas as pessoas autistas; há, entretanto, vulnerabilidades de saúde física que merecem pesquisa e vigilância. [R65]

Temas futuros incluem demência e diferenciação de declínio cognitivo, menopausa, polifarmácia, mobilidade, solidão, moradia, cuidadores envelhecendo e sucessão de suporte.

## PARTE VIII - FAMÍLIA, CUIDADORES E REDE DE APOIO

Cuidar de quem cuida faz parte do cuidado baseado em evidências.

### 50. Sobrecarga do cuidador é um desfecho clínico relevante

O cuidado de uma pessoa com altas necessidades de suporte pode envolver privação de sono, crises, coordenação de terapias, escola, saúde, burocracia e pressão financeira. Tratar o bem-estar do cuidador como “assunto secundário” prejudica toda a família.

Uma network meta-analysis de 2024 reuniu 69 estudos e 4.213 pais; intervenções baseadas em mindfulness tiveram maior desempenho para estresse parental e TCC mostrou benefício para ansiedade/depressão. [R66] Uma meta-análise de 2025 de 12 RCTs também encontrou redução de estresse, ansiedade e depressão parental com intervenções baseadas em mindfulness. [R67]

### 51. WHO Caregiver Skills Training

A OMS desenvolveu um pacote de Treinamento de Habilidades para Cuidadores (CST) para famílias de crianças de 2 a 9 anos com atraso do desenvolvimento ou deficiência. O programa utiliza brincadeiras e rotinas do cotidiano para favorecer engajamento, comunicação, comportamento positivo e vida diária. Em 2026, a OMS acrescentou um módulo específico de bem-estar dos cuidadores, e a OPAS disponibilizou o conjunto em português. [R68,R69]

**Família parceira não significa família transformada em equipe terapêutica 24 horas por dia. Descanso, trabalho, relacionamento conjugal, irmãos, lazer e saúde do cuidador também são necessidades legítimas.**

### 52. Irmãos e rede familiar

Irmãos podem vivenciar afeto, orgulho, preocupação, ciúme, responsabilidades precoces ou sensação de invisibilidade. Informações adequadas à idade, tempo individual com os pais e possibilidade de expressar sentimentos são componentes importantes. Planejamento de futuro não deve presumir automaticamente que irmãos adultos assumirão cuidado integral.

### 53. Plano de proteção do cuidador

- Mapear pessoas de confiança que conheçam a rotina da pessoa autista.
- Manter lista atualizada de medicamentos, alergias, profissionais e contatos.
- Criar rotinas de descanso/respiro quando disponíveis.
- Definir quem assume decisões e cuidados em emergência do cuidador.
- Buscar apoio psicológico/psiquiátrico quando houver depressão, ansiedade, exaustão ou risco de violência.
- Separar crise da criança e exaustão do cuidador: ambos podem precisar de plano específico.

## PARTE IX - MENINAS, MULHERES, CAMUFLAGEM E DIAGNÓSTICO TARDIO

A apresentação do espectro pode fugir do protótipo histórico masculino.

### 54. Viés diagnóstico e fenótipo

Revisões indicam que meninas e mulheres podem ser subdiagnosticadas ou receber diagnósticos alternativos antes do reconhecimento do TEA. Interesses restritos podem parecer socialmente comuns, e algumas pessoas desenvolvem estratégias sofisticadas de imitação, ensaio de scripts, supressão de stimming e estudo explícito das regras sociais. [R52-R55]

### 55. Camuflagem/masking

Camuflagem descreve estratégias conscientes ou não para mascarar, compensar ou assimilar características autísticas em ambientes sociais. Uma meta-análise de 2026, com 50 trabalhos e 16.895 participantes, encontrou associação moderada entre traços autísticos e camuflagem ( $r \approx 0,34$ ), com nuances importantes de método e grupo. [R54]

Outras meta-análises encontram diferenças por sexo dependendo do instrumento, e mulheres autistas podem pontuar mais em medidas específicas de camuflagem. Portanto, “mulheres sempre mascaram mais” não deve ser tratado como regra universal.

Camuflagem prolongada pode ser exaustiva e associar-se a sofrimento psicológico. Avaliação diagnóstica adulta deve considerar história de desenvolvimento, custo da adaptação social e discrepância entre desempenho aparente e esforço necessário.

### 56. Ciclo de vida feminino

Menstruação, contracepção, gravidez, pós-parto e menopausa podem interagir com sensorialidade, interocepção, dor e saúde mental. A literatura sobre menopausa em mulheres autistas é recente e ainda pequena; é uma prioridade de pesquisa, não um campo com respostas consolidadas.

## PARTE X - ALTAS NECESSIDADES DE SUPORTE E O DEBATE SOBRE “AUTISMO PROFUNDO”

Como reconhecer necessidades intensas sem transformar um termo administrativo em subtipo biológico não comprovado.

### 57. Por que surgiu o termo

A Lancet Commission de 2022 propôs “profound autism” como termo administrativo, não como novo diagnóstico, para chamar atenção a pessoas com necessidades de suporte muito elevadas e de longa duração - frequentemente com deficiência intelectual importante e/ou linguagem mínima. Em diferentes coortes, a proporção estimada variou amplamente. [R24,R70]

O termo gerou debate entre pesquisadores, familiares e pessoas autistas. Críticos temem simplificação excessiva de necessidades multidimensionais e potencial uso segregador; defensores argumentam que um rótulo de planejamento evita que pessoas com maior dependência desapareçam da pesquisa e da política pública.

### 58. Não é um subtipo biológico estabelecido

Em 2026, um preprint com análises genômicas, transcriptômicas e regulatórias não encontrou suporte para “autismo profundo” como categoria biológica distinta. Por ser preprint, ainda requer revisão por pares e replicação, mas reforça a cautela contra tratar o termo como entidade molecular. [R71]

**Mais útil que um rótulo único: registrar linguagem funcional, comunicação alternativa, cognição, autocuidado, segurança, epilepsia, sono, comportamento, mobilidade e nível de supervisão necessário.**

### 59. Prioridades para pessoas com suporte intenso

- Comunicação funcional acessível, incluindo CAA e acesso consistente ao sistema.
- Avaliação de dor e saúde física diante de mudanças comportamentais.
- Prevenção e tratamento de autoagressão/agressão com análise funcional e segurança.
- Epilepsia, sono, alimentação/deglutição e constipação monitorados ativamente.
- Treino de autonomia realista e dignidade em higiene e autocuidado.
- Planejamento de cuidadores, moradia e suporte financeiro para a vida adulta.
- Evitar metas cosméticas que consomem tempo sem melhorar vida ou segurança.

## PARTE XI - SAÚDE INTEGRAL, CRISES, SEGURANÇA E PREVENÇÃO

Comportamento pode ser comunicação; saúde física e mental não podem ser eclipsadas pelo diagnóstico.

### 60. Crises: meltdown, comportamento que desafia e análise de contexto

“Crise” é uma descrição, não uma etiologia. NICE recomenda investigar comunicação, dor e condições físicas, ansiedade/depressão/TDAH, iluminação e ruído, ambiente social, mudanças de rotina, puberdade, exploração/abuso, reforçamento inadvertido e falta de previsibilidade. [R06]

Um registro ABC - antecedente, comportamento, consequência - pode ajudar a encontrar padrões. Exemplo: retirada do tablet → gritos/agressão → devolução do tablet. Isso não serve para culpar ninguém; serve para identificar funções e oportunidades de prevenção, comunicação alternativa e mudança de contingências.

### 61. Dor e “comportamento novo”

Mudança abrupta de sono, alimentação, irritabilidade, autoagressão, recusa de atividades ou despertar noturno pode exigir investigação de causas médicas: constipação, refluxo, dor dentária, otite, cefaleia, lesões, infecção urinária, dismenorreia, efeitos adversos de medicamentos e outras condições. Em pessoas com comunicação limitada, a expressão de dor pode ser atípica.

### 62. Epilepsia

Epilepsia é mais frequente em pessoas autistas do que na população geral, especialmente quando há deficiência intelectual. As estimativas variam muito com idade e amostra. Episódios de perda de consciência, movimentos paroxísticos, regressão abrupta ou alterações suspeitas devem ser avaliados por equipe médica; EEG não é exame diagnóstico de autismo.

### 63. Sono

Antes de atribuir insônia ao TEA, revisar rotina, luz/telas, atividade, apneia, refluxo, dor, ansiedade, epilepsia e medicamentos. Estratégias comportamentais e ambientais são primeira linha em muitos casos. Melatonina possui evidência para alguns problemas de sono, sob orientação clínica.

### 64. Alimentação e gastrointestinal

Constipação, seletividade alimentar, refluxo e outros sintomas gastrointestinais são frequentes e merecem tratamento baseado em diagnóstico. Não se deve interpretar sintomas GI como prova de que “o intestino causa autismo”. Avaliar crescimento, ferro, vitamina D, B12 e outros nutrientes pode ser necessário em seletividade intensa, conforme história clínica e dieta.

### 65. Fuga/elopement e segurança

Algumas crianças e adultos podem sair repentinamente de locais seguros ou aproximar-se de água/trânsito. O plano deve combinar prevenção ambiental, identificação, ensino funcional de parar/esperar, comunicação, supervisão proporcional ao risco e informação à escola/cuidadores. Dispositivos de localização podem ser camada adicional, não substituto da supervisão e do ensino.

### 66. Vitimização, abuso e segurança digital

O risco agregado de vitimização é elevado e heterogêneo. Educação explícita sobre limites, consentimento, golpes, segurança online e como denunciar situações deve ser adaptada à comunicação e ao nível de compreensão. Profissionais precisam considerar exploração ou abuso como possível fator quando comportamento muda subitamente. [R59]

### 67. Saúde mental e risco suicida

Estudos mostram risco de suicídio maior em pessoas autistas do que em não autistas. Uma meta-análise global de 2024 estimou risco relativo de mortalidade por suicídio aproximadamente 2,85, embora o número de estudos e a cobertura

geográfica fossem limitados. [R72] Meta-análises em jovens mostram heterogeneidade muito elevada entre métodos e informantes. [R73]

Aplicação prática: ansiedade, depressão, bullying, isolamento, trauma, perda de suporte e ideação suicida devem ser perguntados diretamente e tratados. Ferramentas de avaliação de risco precisam ser adaptadas à comunicação da pessoa; jamais se deve presumir que “isso é apenas autismo”.

## PARTE XII - BRASIL: SUS, SAÚDE SUPLEMENTAR, EDUCAÇÃO E DIREITOS

Panorama atualizado até 21 de setembro de 2026; inclui o texto vigente consultado da Lei nº 12.764/2012, do Decreto nº 8.368/2014, do ECA, da LBI e da LOAS. Verificar alterações posteriores antes de uso jurídico.

### 68. Marco legal principal

| Ano  | Norma                                   | Relevância                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 | Lei 12.764 - Lei Berenice Piana         | Institui Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA; considera pessoa com TEA pessoa com deficiência para todos os efeitos legais; prevê direitos em saúde, educação e outros. [R74]        |
| 2015 | Lei 13.146 - Lei Brasileira de Inclusão | Marco geral de direitos, acessibilidade, não discriminação, educação, trabalho e participação da pessoa com deficiência.                                                                                      |
| 2019 | Lei 13.861                              | Determinou inclusão de especificidades inerentes ao TEA nos censos demográficos; embasou a coleta do Censo 2022.                                                                                              |
| 2020 | Lei 13.977 - Lei Romeo Mion             | Cria a CIPTEA - Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.                                                                                                                       |
| 2023 | Lei 14.626                              | Inclui expressamente pessoas com TEA no atendimento prioritário e altera regras de assentos reservados. [R75]                                                                                                 |
| 2024 | Lei 14.880                              | Institui diretrizes de atenção precoce na educação especial para crianças de 0 a 3 anos com sinais de alerta/necessidades, incluindo prioridade em serviços e visita domiciliar em situações previstas. [R76] |
| 2025 | Lei 15.131                              | Especifica nutrição adequada e terapia nutricional na Lei 12.764, por profissional legalmente habilitado e observando protocolos/diretrizes. [R77]                                                            |
| 2025 | Lei 15.256                              | Acrescenta incentivo à investigação diagnóstica de TEA em pessoas adultas e idosas. [R78]                                                                                                                     |

### 69. SUS: porta de entrada e rede

O Ministério da Saúde orienta que o cuidado comece preferencialmente na Atenção Primária/UBS. Quando necessário, crianças, adolescentes e adultos podem ser encaminhados para CER, CAPS/CAPSi, policlínicas ou outros serviços especializados, mantendo articulação com a equipe de referência. CERs podem realizar diagnóstico, reabilitação e tecnologia assistiva; CAPS/CAPSi são relevantes quando coexistem problemas graves de saúde mental. [R79]

Em 2026, o Ministério realizou consulta pública para revisão e atualização do “Guia de Cuidado Integral às Pessoas com TEA”, com abordagem ao longo de todo o ciclo de vida e articulação da Rede de Atenção à Saúde. A consulta ocorreu de 27/02 a 14/03/2026 e está oficialmente marcada como encerrada; até a data de atualização deste dossiê, a página consultada não demonstrava uma versão final oficialmente publicada após a consulta. [R80,R81]

## 70. Saúde suplementar/ANS

Desde julho de 2022, a ANS ampliou a cobertura para métodos/técnicas indicados pelo médico assistente para beneficiários enquadrados nos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, nos procedimentos abrangidos. A RN 541 também eliminou limites de sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia para planos regulamentados com cobertura ambulatorial. [R82-R84]

Cobertura concreta depende do tipo de plano, segmentação, carência, rede e normas vigentes. Para orientação jurídica individual, devem ser consultados contrato, ANS, Procon/Defensoria e profissional jurídico quando necessário.

## 71. Educação e acompanhante

A Lei 12.764 prevê acesso à educação e, em caso de comprovada necessidade, acompanhante especializado conforme a legislação aplicável. A LBI e normas educacionais complementam o dever de inclusão. O AEE é complementar, não substitutivo, e deve eliminar barreiras à participação. [R61,R74]

## 72. CIPTEA

A CIPTEA tem finalidade de facilitar atenção integral, prioridade e identificação. Procedimentos de emissão são organizados por estados/municípios e podem variar operacionalmente. A existência da carteira não cria o diagnóstico; ela documenta condição já reconhecida nos termos administrativos.

## 72-A. Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012): direitos explicados em linguagem simples

A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Seu ponto jurídico central é direto: a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso faz com que, além dos direitos escritos na própria Lei Berenice Piana, também sejam aplicáveis à pessoa autista os direitos previstos na legislação geral da pessoa com deficiência, especialmente a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). O texto da Lei nº 12.764 foi alterado ao longo dos anos, inclusive em 2020 e 2025; por isso, este dossiê considera o texto legal atualizado até setembro de 2026. [R74,R90]

Em termos simples: a lei não cria apenas um “direito ao diagnóstico”. Ela estabelece proteção à dignidade, saúde, educação, profissionalização, trabalho, moradia, previdência e assistência social, além de proteção contra abuso, exploração e discriminação. O Decreto nº 8.368/2014 regulamenta pontos importantes da lei, especialmente saúde, proteção social e educação inclusiva. [R74,R88]

| Área                             | O que a lei garante, em termos simples                                                                                                                                                                                    | O que isso significa na prática                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Educação                         | Acesso à educação e ao ensino profissionalizante; inclusão no ensino regular; acompanhante especializado quando houver necessidade comprovada.                                                                            | A escola não pode excluir o estudante por ser autista. Quando houver necessidade de apoio em comunicação, interação social, locomoção, alimentação ou cuidados pessoais, o Decreto nº 8.368/2014 determina que a instituição disponibilize acompanhante especializado no contexto escolar. [R74,R88] |
| Saúde                            | Atenção integral; diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; atendimento multiprofissional; nutrição adequada; terapia nutricional quando indicada; medicamentos e informações que auxiliem diagnóstico e tratamento. | No SUS, o cuidado deve respeitar as necessidades da pessoa e pode envolver atenção primária, especializada e hospitalar, saúde bucal, atenção psicossocial, habilitação, reabilitação e projeto terapêutico singular. [R74,R88]                                                                      |
| Assistência social e previdência | Acesso à previdência social e à assistência social.                                                                                                                                                                       | A pessoa autista e sua família podem acessar serviços, programas e benefícios conforme os requisitos de cada política. O BPC pode ser devido à pessoa com deficiência de baixa renda que cumpra os critérios legais; o diagnóstico de TEA, sozinho, não torna a concessão automática. [R74,R91,R92]  |
| Trabalho                         | Estímulo à inserção no mercado de trabalho, consideradas as peculiaridades e necessidades da pessoa.                                                                                                                      | A proteção se articula à LBI e à legislação trabalhista e de inclusão. Para adolescentes, devem ser respeitadas também as regras protetivas do ECA. [R74,R90]                                                                                                                                        |
| Moradia                          | Acesso à moradia, inclusive residência protegida.                                                                                                                                                                         | O direito deve ser interpretado junto às políticas de assistência social, moradia e à LBI, especialmente quando a pessoa necessita de apoio                                                                                                                                                          |

| Área                       | O que a lei garante, em termos simples                                                                                                                                                    | O que isso significa na prática                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                           | para vida independente ou proteção social. [R74,R90]                                                                                                                                              |
| Dignidade e segurança      | Vida digna; integridade física e moral; livre desenvolvimento da personalidade; segurança; lazer; proteção contra abuso e exploração.                                                     | A pessoa autista não pode ser submetida a tratamento desumano ou degradante, privada arbitrariamente da liberdade ou do convívio familiar nem discriminada em razão da deficiência. [R74]         |
| Planos de saúde            | A condição de pessoa com TEA não pode, por si só, impedir participação em plano privado de assistência à saúde.                                                                           | A cobertura concreta depende da legislação de saúde suplementar e do contrato aplicável, mas a deficiência não pode ser usada como motivo para impedir a participação no plano. [R74]             |
| Prioridade e identificação | A CIPTEA busca assegurar atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e acesso a serviços públicos e privados, especialmente em saúde, educação e assistência social. | A emissão é organizada por estados, Distrito Federal e municípios. A carteira facilita a identificação e o exercício da prioridade; não substitui avaliação clínica nem cria o diagnóstico. [R74] |

## 72-A.1 Educação: quais são os direitos do estudante autista?

O direito à educação não se resume a conseguir uma vaga. A leitura conjunta da Lei Berenice Piana, do Decreto nº 8.368/2014, da Lei Brasileira de Inclusão e do Estatuto da Criança e do Adolescente exige acesso, permanência, participação e aprendizagem em sistema educacional inclusivo. [R74,R88,R89,R90]

- A matrícula não pode ser recusada pelo fato de o estudante ter TEA. A Lei nº 12.764 estabelece multa de 3 a 20 salários-mínimos ao gestor escolar ou à autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com TEA ou outra deficiência; em caso de reincidência, observadas as garantias do processo administrativo, pode haver perda do cargo. [R74]
- O estudante tem direito à educação em sistema inclusivo, com a educação especial atravessando as etapas desde a educação infantil até a educação superior. [R88]
- Quando houver necessidade comprovada, há direito a acompanhante especializado. O Decreto nº 8.368/2014 esclarece que esse apoio pode ser necessário em comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. Não se deve concluir que todo diagnóstico exige automaticamente acompanhamento individual em tempo integral; a necessidade precisa ser analisada no contexto do estudante. [R74,R88]
- A LBI exige medidas de acessibilidade, oferta de profissionais de apoio escolar, participação da família, práticas pedagógicas inclusivas e recursos de tecnologia assistiva. Nas instituições privadas, a lei veda cobrança adicional de mensalidade, anuidade ou matrícula para cumprir as medidas de inclusão listadas no art. 28, § 1º. [R90]
- O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é complementar ou suplementar à escolarização, conforme a necessidade, e não deve ser utilizado para afastar automaticamente o estudante da classe comum. [R61,R90]
- Adaptação não significa “facilitar tudo” nem retirar do estudante o direito de aprender. Significa remover barreiras: ajustar comunicação, ambiente, materiais, avaliação, tempo, tecnologia assistiva, estratégias pedagógicas ou formas de participação quando isso for necessário para igualdade de oportunidades. [R90]

Exemplo prático: uma criança autista que compreende o conteúdo, mas entra em sobrecarga com ruído e possui comunicação limitada pode necessitar de ambiente mais previsível, instruções visuais, possibilidade de pausa, recurso de comunicação aumentativa e alternativa e apoio de profissional em determinadas atividades. O objetivo é permitir participação e aprendizagem, não isolá-la do restante da turma.

## 72-A.2 Saúde: o que a Lei Berenice Piana assegura?

A lei reconhece o direito de acesso a ações e serviços de saúde voltados à atenção integral. Ela menciona expressamente diagnóstico precoce, mesmo quando ainda não definitivo, atendimento multiprofissional, nutrição adequada e terapia nutricional quando indicadas, medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. [R74]

- O diagnóstico não precisa estar “fechado” para que atrasos ou necessidades já identificadas deixem de ser acompanhados. A criança pode receber apoio para linguagem, alimentação, desenvolvimento, sono ou outras necessidades enquanto a investigação diagnóstica continua.
- O Decreto nº 8.368/2014 garante à pessoa com TEA o direito à saúde no SUS, respeitadas suas especificidades, e prevê cuidado integral na atenção básica, especializada e hospitalar. [R88]
- O cuidado pode incluir diagnóstico diferencial, estimulação precoce, habilitação, reabilitação, atenção psicossocial, saúde bucal e outras intervenções definidas de maneira individualizada no projeto terapêutico singular. [R88]
- Medicamentos devem ser prescritos para indicações clínicas específicas e conforme evidência e monitoramento. A Lei nº 12.764 não significa que exista medicamento capaz de “curar o autismo”.
- Nas consultas e procedimentos, adaptações de comunicação, previsibilidade, tempo e ambiente podem ser necessárias para que a pessoa realmente consiga acessar o cuidado em igualdade de condições.

## 72-A.3 Assistência social, BPC e proteção da família

A Lei nº 12.764 garante acesso à previdência social e à assistência social. O Decreto nº 8.368/2014 acrescenta que a pessoa com TEA em situação de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal tem direito à proteção social nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). [R74,R88,R91]

É importante separar duas ideias: ter TEA coloca a pessoa sob a proteção jurídica destinada às pessoas com deficiência, mas isso não torna automaticamente devido todo benefício financeiro. Cada benefício possui requisitos próprios.

- Benefício de Prestação Continuada (BPC): é um benefício assistencial no valor de um salário-mínimo mensal destinado à pessoa com deficiência que também cumpra os critérios socioeconômicos e administrativos aplicáveis. Não exige contribuição prévia ao INSS. [R91,R92]
- Para o BPC, o diagnóstico médico de TEA é importante, mas não basta sozinho: a concessão envolve avaliação da deficiência e das barreiras/impactos funcionais, além da análise da renda e dos demais requisitos legais. [R91,R92]
- O Cadastro Único (CadÚnico) da família precisa estar atualizado para o requerimento administrativo do BPC. O CRAS pode orientar a família sobre CadÚnico, rede socioassistencial e serviços locais; o pedido do BPC é processado pelo INSS. [R92]
- A pessoa com deficiência que recebia BPC e ingressa no trabalho pode, se preencher os requisitos próprios, ter acesso ao Auxílio-Inclusão. As regras devem sempre ser conferidas na data do pedido, pois podem sofrer alterações. [R91,R93]

Mensagem-chave para famílias: “autismo dá direito ao BPC” é uma frase incompleta. A formulação correta é: a pessoa autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e pode ter direito ao BPC quando preencher os requisitos específicos da legislação assistencial.

## 72-A.4 Outros direitos importantes previstos ou reforçados pela Lei nº 12.764

- Não discriminação: a pessoa autista não pode sofrer discriminação por motivo de deficiência. [R74]
- Convivência familiar: a pessoa não deve ser privada do convívio familiar em razão do TEA. [R74]
- Proteção contra abuso e exploração: a lei assegura proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. [R74]
- Vida digna, integridade, personalidade, segurança e lazer: são direitos expressamente reconhecidos no art. 3º. [R74]
- Pesquisa, informação e capacitação: a política nacional prevê informação pública sobre TEA, formação de profissionais e de pais/responsáveis e incentivo à pesquisa científica. [R74]
- Diagnóstico em adultos e idosos: desde alteração legislativa de 2025, a política nacional inclui incentivo à investigação diagnóstica do TEA em adultos e pessoas idosas. [R74,R78]

## 72-B. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) protege a criança e o adolescente autista

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069/1990) protege todas as crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência. Para uma criança ou adolescente autista, a proteção da Lei Berenice Piana não substitui o ECA: as duas normas se somam. O ECA adota o princípio da proteção integral e afirma expressamente que seus direitos se aplicam sem discriminação por deficiência ou condição de desenvolvimento e aprendizagem. [R89]

| <b>Tema no ECA</b>                          | <b>Proteção relevante para a criança/adolescente autista</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Exemplo prático</b>                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção integral e prioridade absoluta     | Família, sociedade e poder público devem assegurar com prioridade direitos como vida, saúde, educação, alimentação, lazer, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. [R89]                                                                                  | Uma criança autista não deve ter seu acesso a saúde ou educação tratado como favor; são direitos protegidos com prioridade.                               |
| Não discriminação, violência ou negligência | O ECA proíbe negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; também protege a integridade física, psíquica e moral. [R89]                                                                                                                          | Humilhar uma criança por uma crise, ridicularizar sua comunicação ou usar violência como “método educativo” viola direitos.                               |
| Saúde                                       | O art. 11 assegura acesso integral às linhas de cuidado pelo SUS e determina que crianças e adolescentes com deficiência sejam atendidos sem discriminação ou segregação, inclusive em habilitação e reabilitação. [R89]                                                    | A criança pode precisar de atendimento adaptado, recursos assistivos ou encaminhamento especializado, sem ser segregada do cuidado geral de saúde.        |
| Educação                                    | Os arts. 53 e 54 asseguram educação, igualdade de condições para acesso e permanência, respeito pelos educadores, participação dos pais no processo pedagógico e atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular. [R89] | A escola deve trabalhar para garantir permanência e aprendizagem; não basta aceitar a matrícula e depois criar barreiras que inviabilizem a frequência.   |
| Prevenção e proteção contra violência       | O art. 70 estabelece dever geral de prevenir ameaça ou violação de direitos; famílias com crianças e adolescentes com deficiência têm prioridade nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. [R89]                                                              | Escola e serviços de saúde devem possuir profissionais capazes de reconhecer e comunicar situações de violência ou crimes contra crianças e adolescentes. |
| Medidas de proteção                         | Quando um direito é ameaçado ou violado por ação/omissão do Estado, da sociedade, dos responsáveis ou em razão da própria situação da criança/adolescente, podem ser aplicadas medidas protetivas. [R89]                                                                    | Podem envolver orientação e acompanhamento, matrícula/frequência escolar, inclusão em serviços de proteção e acesso a tratamento ou apoio adequado.       |

## 72-B.1 Educação e ECA: acesso, permanência, respeito e participação da família

O art. 53 do ECA estabelece igualdade de condições para acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado pelos educadores e o direito dos pais ou responsáveis de conhecer o processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais. O art. 54 prevê atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular. [R89]

Para o estudante autista, isso é importante porque inclusão escolar não pode ser reduzida a “estar matriculado”. Se barreiras sensoriais, comunicacionais, pedagógicas ou de apoio tornam impossível sua presença ou aprendizagem, a escola e a rede precisam analisar medidas adequadas, em articulação com a família e os profissionais envolvidos.

## 72-B.2 Saúde e dignidade pelo ECA

O ECA assegura proteção à vida e à saúde e, no art. 11, garante acesso integral às linhas de cuidado do SUS. Para crianças e adolescentes com deficiência, o atendimento deve ocorrer sem discriminação ou segregação e abranger necessidades gerais de saúde e necessidades específicas de habilitação e reabilitação. O poder público também deve fornecer, a quem necessitar, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relacionadas ao tratamento, habilitação ou reabilitação, conforme as linhas de cuidado aplicáveis. [R89]

Os arts. 15 a 18 também protegem liberdade, respeito, dignidade e integridade física, psíquica e moral. Crianças e adolescentes têm direito de ser cuidados e educados sem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Isso vale igualmente para casa, escola, serviços de saúde, instituições e qualquer pessoa responsável pelo cuidado. [R89]

## 72-B.3 Quando um direito está sendo negado: qual é o papel do Conselho Tutelar?

O Conselho Tutelar é um órgão de proteção dos direitos da criança e do adolescente; não substitui médico, escola, Defensoria, Ministério Público ou juiz. Entretanto, quando um direito previsto no ECA é ameaçado ou violado, o Conselho pode aplicar medidas de proteção dentro de suas atribuições e requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança. Também pode representar às autoridades competentes quando suas deliberações são descumpridas. [R89]

Isso torna o Conselho Tutelar uma porta importante quando, por exemplo, uma criança ou adolescente autista está fora da escola por recusa de matrícula, não consegue acessar serviço público essencial, sofre violência, negligência, humilhação ou outra violação de direito. Cada caso, porém, deve ser documentado e encaminhado ao órgão adequado.

## 72-C. Roteiro prático para famílias diante de possível violação de direitos

Este roteiro é informativo e não substitui orientação jurídica individual. Em situações urgentes de risco à integridade física ou à vida, procure imediatamente os serviços de emergência e proteção competentes.

- 1. Identifique o direito e registre os fatos: anote datas, nomes, protocolos, e-mails, relatórios e o que foi solicitado ou negado.
- 2. Peça a negativa ou resposta por escrito sempre que possível. Uma recusa verbal é muito mais difícil de demonstrar depois.
- 3. Educação: procure direção/coordenação, Secretaria Municipal ou Estadual de Educação e os canais de ouvidoria. Para criança ou adolescente, o Conselho Tutelar pode atuar quando houver ameaça ou violação de direito. Casos persistentes podem exigir Defensoria Pública, Ministério Público ou advogado.
- 4. Saúde pública: utilize a unidade responsável, regulação/Secretaria de Saúde e Ouvidoria do SUS. Quando houver violação persistente, Defensoria Pública ou Ministério Público podem ser procurados.
- 5. Assistência social: procure CRAS/CREAS conforme a situação, mantenha o CadÚnico atualizado quando aplicável e utilize os canais oficiais do INSS para BPC e benefícios relacionados.
- 6. Escola particular: lembre que a LBI veda cobrança adicional para cumprimento das obrigações inclusivas previstas em seu art. 28, § 1º. Guarde contratos, comunicados e cobranças. [R90]
- 7. Violência, abuso, exploração ou tratamento degradante: além do Conselho Tutelar, podem ser acionados os canais de segurança pública, Disque 100, Ministério Público e demais órgãos competentes, conforme a gravidade e a situação.

## 72-D. O que a Lei Berenice Piana não significa

- O diagnóstico de TEA não gera automaticamente BPC, aposentadoria, benefício financeiro ou acompanhante individual em todas as situações. Cada direito possui critérios próprios.
- Acompanhante especializado não significa necessariamente um profissional exclusivo durante 100% do tempo escolar; a necessidade e a forma de apoio devem ser analisadas no caso concreto, respeitando a legislação e as barreiras apresentadas.
- Inclusão não significa retirar expectativas de aprendizagem. Significa oferecer acessibilidade, apoio e estratégias compatíveis para permitir participação e desenvolvimento.
- A Lei nº 12.764 não autoriza qualquer terapia nem obriga família a seguir método específico. Tratamentos e intervenções precisam respeitar indicação clínica, evidência, segurança, ética e preferência/necessidade da pessoa.
- A CIPTEA facilita identificação e prioridade, mas não substitui laudo ou documentação específica quando determinado serviço legalmente exigir comprovação própria.

Nota jurídica editorial: legislação e procedimentos administrativos podem mudar. Antes de usar este capítulo em requerimento, recurso ou ação judicial, confira o texto oficial atualizado e, quando necessário, procure a Defensoria Pública ou profissional jurídico habilitado.

## PARTE XIII - FATORES ASSOCIADOS E CAUSALIDADE: COMO INTERPRETAR RISCOS

Por que “aumenta o risco” não significa “causou o autismo desta criança”.

### 73. Uma tabela de calibração causal

| Fator                          | O que a literatura sugere                                                                          | Cuidado de interpretação                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genética                       | Contribuição forte e consistente; herdabilidade elevada e centenas de genes/variantes associados.  | Não existe “um gene do autismo”; risco é poligênico/heterogêneo.                               |
| Valproato gestacional          | Associação consistente e clinicamente importante; meta-análises recentes mostram aumento de risco. | Decisões sobre anticonvulsivantes devem ser médicas; não interromper abruptamente.             |
| Diabetes materno               | Meta-análises recentes mostram associação modesta a moderada, variando com tipo de diabetes.       | Associação populacional; grande maioria dos filhos de mães diabéticas não terá TEA.            |
| Idade parental elevada         | Associação modesta em meta-análises.                                                               | Pode refletir mecanismos biológicos e confundidores; não é causa individual simples.           |
| Infecção materna               | Meta-análises encontram associação pequena/modesta em alguns contextos.                            | Definição de infecção e controle de confundidores variam.                                      |
| Poluição do ar                 | Alguns estudos encontram associação com PM2.5/NOx; resultados e janelas de exposição variam.       | Certeza ainda limitada; não permite atribuição individual.                                     |
| Prematuridade/baixo peso       | Risco de diagnóstico de TEA é maior em prematuros, sobretudo extremos.                             | Pode refletir múltiplos mecanismos perinatais e vulnerabilidade geral do neurodesenvolvimento. |
| Paracetamol gestacional        | Associações convencionais enfraquecem em desenhos familiares/irmãos.                               | Não há evidência conclusiva de causalidade; evitar alarmismo.                                  |
| Vacinas                        | Grandes estudos e revisões não mostram relação causal.                                             | Mito refutado; não se deve usar coincidência temporal como prova.                              |
| Estilo parental/falta de afeto | Não causa TEA.                                                                                     | Teoria histórica refutada e danosa.                                                            |

| Fator | O que a literatura sugere                                                                                            | Cuidado de interpretação                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Telas | Excesso pode afetar sono/interação/desenvolvimento em qualquer criança, mas não está estabelecido como causa do TEA. | Correlação comportamental não equivale a etiologia. |

## 74. Risco relativo não é risco absoluto

Se um fator aumenta um risco relativo de 1 para 1,5, isso não significa que 50% das pessoas expostas terão o desfecho. É necessário conhecer o risco de base. Estudos observacionais também podem sofrer confusão residual, seleção e erro de medição. Quando uma associação desaparece em comparações entre irmãos, isso sugere que fatores familiares/genéticos compartilhados explicavam parte do resultado.

## PARTE XIV - COMO AVALIAR CIÊNCIA, TERAPIAS E ALEGAÇÕES DE CURA

Uma alfabetização científica prática para famílias.

### 75. Dez perguntas para qualquer “novo tratamento”

1. O estudo é randomizado e possui grupo-controle adequado?
2. Quantas pessoas participaram e quantas abandonaram?
3. Quem avaliou o resultado sabia quem recebeu o tratamento?
4. O desfecho é clinicamente importante ou apenas um escore?
5. O efeito é grande o suficiente para ser percebido na vida real?
6. Houve acompanhamento após terminar a intervenção?
7. O resultado foi replicado por grupos independentes?
8. Eventos adversos foram procurados sistematicamente?
9. Os autores ou a clínica têm conflito financeiro relevante?
10. O artigo foi corrigido, retratado ou contestado posteriormente?

### 76. Red flags de pseudociência

- Promessa de “cura”, “reversão garantida” ou porcentagens de sucesso sem publicação independente.
- Explicação única para todos os casos: metais, parasitas, “inflamação”, glúten ou vacina.
- Testes próprios vendidos pela mesma clínica que vende o tratamento.
- Antes/depois sem grupo-controle apresentados como prova.
- Depoimentos de famílias substituindo dados clínicos.
- Pressão para comprar imediatamente ou pacotes caros.
- Alegação de conspiração: “médicos não querem que você saiba”.
- Recomendação de suspender tratamento médico convencional sem avaliação.
- Produto com composição incerta, doses não padronizadas ou importação clandestina.
- Rejeição de perguntas sobre efeitos adversos e evidência negativa.

### 77. Retrações importam

Ciência se autocorrige. Um artigo retratado não deve continuar sendo citado como evidência positiva. O caso do RCT de ácido folínico publicado em 2024 e retratado em janeiro de 2026 é um exemplo didático: qualquer revisão atualizada precisa sinalizar explicitamente a retratação. [R42]

### 78. Conflito de interesse não invalida automaticamente um estudo

Financiamento empresarial ou patente não prova fraude, mas aumenta a necessidade de transparência, replicação independente e atenção ao desenho/relato seletivo. O mesmo vale para pesquisadores que desenvolveram uma terapia que depois avaliam. O acervo deve registrar conflitos quando relevantes.

## PARTE XV - MITOS E FATOS

Respostas curtas para dúvidas que mais circulam entre famílias.

| Mito                                                  | Estado da evidência                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Vacina causa autismo.”                               | FALSO. Grandes estudos e revisões não demonstram causalidade.                                                                         |
| “Pais frios causam autismo.”                          | FALSO. A teoria da “mãe geladeira” foi um erro histórico.                                                                             |
| “Autismo é uma doença única.”                         | FALSO. É um espectro altamente heterogêneo de condições neurodesenvolvimentais.                                                       |
| “Existe um exame que confirma autismo.”               | FALSO em 2026. Diagnóstico permanece clínico/desenvolvimental.                                                                        |
| “Todo autista tem deficiência intelectual.”           | FALSO. Pode coexistir, mas não é obrigatória.                                                                                         |
| “Todo autista é um gênio.”                            | FALSO. Existem perfis cognitivos muito variados.                                                                                      |
| “Quem fala bem precisa de pouco suporte.”             | FALSO. Linguagem fluente não mede autonomia, saúde mental ou função executiva.                                                        |
| “CAA impede a fala.”                                  | NÃO sustentado. CAA oferece comunicação e pode coexistir com desenvolvimento de fala.                                                 |
| “Quanto mais horas de terapia, melhor.”               | FALSO como regra universal. Intensidade precisa ser individualizada.                                                                  |
| “Todo stimming deve ser interrompido.”                | FALSO. Muitos stims são autorregulatórios e inofensivos; intervenção deve priorizar segurança e função.                               |
| “Crise é manipulação.”                                | NÃO necessariamente. Pode refletir sobrecarga, comunicação, dor, ansiedade, mudança ou contingências de aprendizagem.                 |
| “Dieta sem glúten/caseína trata autismo.”             | NÃO há evidência suficiente para uso rotineiro nas características centrais.                                                          |
| “Intestino causa autismo.”                            | NÃO comprovado. Há pesquisa do eixo intestino-cérebro e maior frequência de sintomas GI, mas causalidade simples não foi demonstrada. |
| “CBD é tratamento comprovado.”                        | FALSO. Evidência permanece limitada e de baixa certeza.                                                                               |
| “Células-tronco já curam autismo.”                    | FALSO. Não há terapia regenerativa aprovada para autismo; cuidado com clínicas comerciais.                                            |
| “Quelantes desintoxicam e melhoram TEA.”              | FALSO e potencialmente perigoso.                                                                                                      |
| “Autismo só existe em crianças.”                      | FALSO. É condição ao longo da vida.                                                                                                   |
| “Meninas quase não têm autismo.”                      | FALSO. Diferenças de apresentação e viés diagnóstico contribuem para sub-reconhecimento.                                              |
| “Diagnóstico é sentença.”                             | FALSO. Necessidades e capacidades mudam; suporte adequado pode melhorar participação e qualidade de vida.                             |
| “Aceitar neurodiversidade significa não tratar nada.” | FALSO. Aceitação pode coexistir com tratamento de epilepsia, ansiedade, dor, sono, autoagressão e outras necessidades.                |

## PARTE XVI - FRONTEIRAS CIENTÍFICAS E AGENDA 2026+

O que é promissor, o que ainda falta e como evitar transformar pesquisa em propaganda prematura.

### 79. Biomarcadores e inteligência artificial

Pesquisas combinam EEG, fNIRS, neuroimagem, eye-tracking, genética, transcriptômica e aprendizado de máquina. Meta-análises de eye-tracking+ML publicadas em 2026 reportam acurácias agregadas altas em conjuntos de pesquisa, mas pequenos tamanhos amostrais, heterogeneidade, risco de overfitting e pouca validação externa impedem uso como exame diagnóstico independente. [R85-R87]

O caminho mais plausível é apoio à decisão clínica e estratificação de risco, não substituição imediata do clínico.

### 80. Genômica de precisão e subgrupos

A próxima fase da genética procura ligar variantes a mecanismos, trajetórias e possíveis respostas terapêuticas. Isso pode ser especialmente relevante em condições monogênicas/sindrômicas. Porém, “medicina de precisão para autismo” ainda está majoritariamente em pesquisa; a heterogeneidade dificulta subtipos simples.

### 81. iPSC e organoides cerebrais

Células-tronco pluripotentes induzidas e organoides permitem modelar etapas do neurodesenvolvimento em laboratório e estudar variantes específicas. São ferramentas de descoberta de mecanismos e triagem pré-clínica; não são equivalentes a “implantar células-tronco” em pessoas autistas.

### 82. Pesquisa participativa

Há crescente demanda para incluir pessoas autistas, familiares e cuidadores no desenho de perguntas, medidas e prioridades. Isso ajuda a deslocar pesquisa de “reduzir pontuação de autismo” para resultados considerados importantes por quem vive a condição: comunicação, segurança, acesso à saúde, emprego, autonomia, pertencimento e qualidade de vida. [R24,R70]

### 83. Grandes lacunas para a próxima década

- Predizer trajetórias individuais sem determinismo.
- Intervenções eficazes para pessoas minimamente falantes e com deficiência intelectual importante.
- Melhores tecnologias e estratégias de CAA para comunicação complexa.
- Prevenção e tratamento de autoagressão grave com menor carga medicamentosa.
- Saúde física e mental de adultos e idosos.
- Modelos sustentáveis de emprego, moradia e apoio comunitário.
- Saúde de mulheres, gravidez, pós-parto e menopausa.
- Prevenção de vitimização, abuso e suicídio.
- Redução de desigualdades de diagnóstico e acesso em países de baixa/média renda.
- Melhor monitoramento de eventos adversos em intervenções não farmacológicas.
- Desfechos funcionais de longo prazo, e não apenas escores de curto prazo.
- Identificação de subgrupos biológicos quando realmente válidos, evitando reificar categorias administrativas.

### 84. Síntese final do estado da arte

Em pouco mais de um século, o autismo passou de um termo ligado à esquizofrenia para uma condição neurodesenvolvimental reconhecida como espectro altamente heterogêneo. Explicações psicogênicas e culpabilizantes foram substituídas por evidência genética e desenvolvimental; categorias rígidas foram substituídas por dimensões e especificadores; a pesquisa migra de uma busca por “uma causa e uma cura” para múltiplas trajetórias e suporte personalizado.

As conclusões mais robustas em 2026 são: TEA é heterogêneo e de origem multifatorial com forte contribuição genética; não é causado pelos pais nem por vacinas; não existe biomarcador diagnóstico único; não existe terapia ou

medicamento que cure o espectro; intervenções podem melhorar alvos específicos; comunicação, participação, saúde e autonomia devem orientar metas; condições coexistentes precisam ser tratadas; pessoas autistas necessitam de atenção durante toda a vida; e qualidade da evidência deve pesar mais que popularidade, depoimentos ou marketing.

## ANEXOS PRÁTICOS

Ferramentas para transformar informação em decisões mais seguras.

### Anexo A - Roteiro após suspeita ou diagnóstico

11. Registrar quais sinais ou dificuldades estão realmente interferindo no cotidiano.
12. Organizar histórico do desenvolvimento, gestação, marcos, linguagem, sono, alimentação e saúde.
13. Realizar avaliação clínica/desenvolvimental por profissionais qualificados; não esperar um teste biológico inexistente.
14. Avaliar audição e visão quando indicado e investigar condições médicas/neurológicas conforme sinais.
15. Iniciar suporte para necessidades claras (por exemplo, comunicação) mesmo quando o processo diagnóstico ainda está em andamento.
16. Definir de três a cinco prioridades funcionais para os próximos meses.
17. Selecionar intervenções baseadas nessas prioridades e estabelecer linha de base.
18. Construir plano de comunicação com escola e demais cuidadores.
19. Revisar sono, alimentação, constipação, dor e saúde bucal.
20. Reavaliar resultados periodicamente e retirar práticas que não oferecem benefício proporcional.

### Anexo B - Sinais que merecem avaliação médica rápida

- Perda súbita ou rápida de habilidades
- Convulsão, desmaio ou episódios de olhar fixo com alteração de consciência
- Autoagressão nova/intensa ou dor aparente
- Recusa alimentar importante, perda de peso ou sinais de desidratação
- Constipação grave, vômitos persistentes ou sangue nas fezes
- Mudança abrupta de sono/estado mental
- Fraqueza, alteração de marcha ou regressão motora
- Febre persistente, dificuldade respiratória ou sinais de infecção
- Ideação suicida, tentativa, violência iminente ou impossibilidade de manter segurança

Em emergência, procure serviço de urgência local. Este dossiê não substitui avaliação clínica.

### Anexo C - Checklist de qualidade de uma clínica/terapia

- ☐ Define objetivos mensuráveis e relevantes?
- ☐ Explica alternativas e incertezas?
- ☐ Registra dados antes e depois?
- ☐ Monitora efeitos adversos e fadiga?
- ☐ Aceita perguntas e segunda opinião?
- ☐ Respeita comunicação e dignidade?
- ☐ Treina generalização para casa/escola sem culpabilizar pais?
- ☐ Não promete cura ou normalização?
- ☐ Possui profissionais habilitados e supervisão?
- ☐ Não vende exames/suplementos como condição para “tratar a causa”?
- ☐ Revê e reduz intervenção se o benefício não aparece?

### Anexo D - Checklist para reunião escolar

- ☐ Como o estudante comunica necessidade, dor e pedido de pausa?
- ☐ Quais gatilhos sensoriais existem?
- ☐ Como são antecipadas mudanças?
- ☐ Quais adaptações de tarefa e avaliação funcionam?
- ☐ Existe acesso consistente à CAA?
- ☐ Como o recreio e refeições são manejados?
- ☐ Há risco de bullying/isolamento?

- ☐ Qual plano para crise e quem é chamado?
- ☐ Quais metas de autonomia e participação serão monitoradas?
- ☐ Como família e escola trocarão dados sem transformar o aluno em um conjunto de problemas?

## Anexo E - Passaporte de saúde/comunicação

| Campo                                         | Preencher |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Nome e como prefere ser chamado               |           |
| Forma de comunicação                          |           |
| Como diz SIM/NÃO                              |           |
| Como demonstra dor                            |           |
| Sensibilidades sensoriais                     |           |
| Gatilhos conhecidos                           |           |
| O que ajuda a regular                         |           |
| Medicamentos/doses                            |           |
| Alergias                                      |           |
| Condições médicas importantes                 |           |
| Risco de fuga/água/trânsito                   |           |
| Contato principal                             |           |
| Profissionais/serviços                        |           |
| Como realizar exame físico com menos estresse |           |

## Anexo F - Glossário de siglas, abreviações e símbolos

Este anexo escreve por extenso as siglas, abreviações e símbolos técnicos utilizados no dossiê. Códigos internos de referência (como R01, R02 e semelhantes), numeração de partes e iniciais de autores não são siglas conceituais e, por isso, não aparecem na tabela. Símbolos gênicos são mantidos na nomenclatura oficial internacional e acompanhados do nome completo.

| Categoria                   | Sigla / símbolo  | Nome por extenso                                                     | Contexto / observação                                                                         |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico e classificação | <b>TEA</b>       | Transtorno do Espectro Autista                                       | Denominação usada no Brasil para Autism Spectrum Disorder.                                    |
| Diagnóstico e classificação | <b>ASD</b>       | Autism Spectrum Disorder                                             | Expressão em inglês correspondente a Transtorno do Espectro Autista.                          |
| Diagnóstico e classificação | <b>DSM</b>       | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders                | Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da American Psychiatric Association. |
| Diagnóstico e classificação | <b>DSM-III</b>   | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition | Terceira edição do DSM, publicada em 1980.                                                    |
| Diagnóstico e classificação | <b>DSM-III-R</b> | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,               | Revisão da terceira edição do DSM, publicada em 1987.                                         |

| <b>Categoria</b>            | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>                                               | <b>Contexto / observação</b>                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                        | Third Edition, Revised                                                |                                                                                                                                 |
| Diagnóstico e classificação | <b>DSM-IV</b>          | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition | Quarta edição do DSM, publicada em 1994.                                                                                        |
| Diagnóstico e classificação | <b>DSM-5</b>           | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition  | Quinta edição do DSM, publicada em 2013; consolidou o conceito de espectro.                                                     |
| Diagnóstico e classificação | <b>CID-11</b>          | Classificação Internacional de Doenças, 11ª Revisão                   | Classificação diagnóstica da Organização Mundial da Saúde.                                                                      |
| Diagnóstico e classificação | <b>ICD-11</b>          | International Classification of Diseases, 11th Revision               | Nome em inglês da CID-11.                                                                                                       |
| Diagnóstico e classificação | <b>PDD-NOS</b>         | Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified            | Categoria diagnóstica histórica do DSM-IV; em português, transtorno invasivo/global do desenvolvimento sem outra especificação. |
| Diagnóstico e classificação | <b>TGD</b>             | Transtorno Global do Desenvolvimento                                  | Denominação histórica ainda presente em normas e documentos brasileiros.                                                        |
| Instrumentos                | <b>M-CHAT-R/F</b>      | Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up    | Instrumento de rastreamento para crianças pequenas; não é teste diagnóstico.                                                    |
| Instrumentos                | <b>ADOS</b>            | Autism Diagnostic Observation Schedule                                | Protocolo observacional padronizado utilizado como parte de avaliações diagnósticas.                                            |
| Instrumentos                | <b>ADOS-G</b>          | Autism Diagnostic Observation Schedule - Generic                      | Versão genérica histórica do ADOS.                                                                                              |
| Instrumentos                | <b>ADOS-2</b>          | Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition                | Segunda edição do protocolo observacional ADOS.                                                                                 |
| Instrumentos                | <b>ADI-R</b>           | Autism Diagnostic Interview - Revised                                 | Entrevista diagnóstica revisada aplicada a cuidador/familiar.                                                                   |
| Instrumentos                | <b>CARS</b>            | Childhood Autism Rating Scale                                         | Escala de avaliação de características autísticas na infância.                                                                  |
| Instrumentos                | <b>CARS-2</b>          | Childhood Autism Rating Scale, Second Edition                         | Segunda edição da CARS.                                                                                                         |
| Intervenções e reabilitação | <b>ABA</b>             | Applied Behavior Analysis                                             | Análise do Comportamento Aplicada.                                                                                              |
| Intervenções e reabilitação | <b>EIBI</b>            | Early Intensive Behavioral Intervention                               | Intervenção Comportamental Intensiva Precoce.                                                                                   |
| Intervenções e reabilitação | <b>NDBI</b>            | Naturalistic Developmental Behavioral Interventions                   | Intervenções Comportamentais Desenvolvimentais Naturalísticas.                                                                  |
| Intervenções e reabilitação | <b>ESDM</b>            | Early Start Denver Model                                              | Modelo Denver de Intervenção Precoce.                                                                                           |
| Intervenções e reabilitação | <b>PRT</b>             | Pivotal Response Treatment                                            | Tratamento de Respostas Pivôs.                                                                                                  |
| Intervenções e reabilitação | <b>JASPER</b>          | Joint Attention, Symbolic Play,                                       | Intervenção voltada a atenção                                                                                                   |

| <b>Categoria</b>            | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>                                                            | <b>Contexto / observação</b>                                                                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                        | Engagement, and Regulation                                                         | conjunta, brincadeira simbólica, engajamento e regulação.                                           |
| Intervenções e reabilitação | <b>PACT</b>            | Paediatric Autism Communication Therapy                                            | Terapia de Comunicação Pediátrica para Autismo.                                                     |
| Intervenções e reabilitação | <b>TEACCH</b>          | Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children | Programa historicamente associado a ensino estruturado, organização visual e apoio à independência. |
| Intervenções e reabilitação | <b>PECS</b>            | Picture Exchange Communication System                                              | Sistema de Comunicação por Troca de Figuras.                                                        |
| Intervenções e reabilitação | <b>CAA</b>             | Comunicação Aumentativa e Alternativa                                              | Conjunto de recursos e estratégias para ampliar ou substituir a fala quando necessário.             |
| Intervenções e reabilitação | <b>AAC</b>             | Augmentative and Alternative Communication                                         | Nome em inglês para Comunicação Aumentativa e Alternativa.                                          |
| Intervenções e reabilitação | <b>CAA/AAC</b>         | Comunicação Aumentativa e Alternativa / Augmentative and Alternative Communication | Forma bilíngue usada no dossiê.                                                                     |
| Intervenções e reabilitação | <b>ASI</b>             | Ayres Sensory Integration                                                          | Integração Sensorial de Ayres.                                                                      |
| Intervenções e reabilitação | <b>DIR</b>             | Developmental, Individual-differences, Relationship-based Model                    | Modelo baseado em desenvolvimento, diferenças individuais e relacionamento; associado ao Floortime. |
| Intervenções e reabilitação | <b>TCC</b>             | Terapia Cognitivo-Comportamental                                                   | Abordagem psicoterapêutica com evidência para alguns problemas associados, como ansiedade.          |
| Intervenções e reabilitação | <b>CBT</b>             | Cognitive Behavioral Therapy                                                       | Nome em inglês para Terapia Cognitivo-Comportamental.                                               |
| Intervenções e reabilitação | <b>CST</b>             | Caregiver Skills Training                                                          | Treinamento de Habilidades para Cuidadores, programa desenvolvido pela OMS e parceiros.             |
| Intervenções e reabilitação | <b>TO</b>              | Terapia Ocupacional                                                                | Área profissional voltada à participação, autonomia e desempenho ocupacional.                       |
| Educação e direitos         | <b>AEE</b>             | Atendimento Educacional Especializado                                              | Serviço da educação especial complementar ou suplementar à escolarização, conforme o caso.          |
| Educação e direitos         | <b>CIPTEA</b>          | Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista             | Documento previsto em legislação brasileira.                                                        |
| Educação e direitos         | <b>LBI</b>             | Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência                               | Lei nº 13.146/2015.                                                                                 |
| Pesquisa e estatística      | <b>RCT</b>             | Randomized Controlled Trial                                                        | Ensaio clínico randomizado/controlado randomizado.                                                  |
| Pesquisa e estatística      | <b>SMD</b>             | Standardized Mean Difference                                                       | Diferença média padronizada, medida de tamanho de efeito.                                           |
| Pesquisa e estatística      | <b>GRADE</b>           | Grading of Recommendations                                                         | Sistema internacional para                                                                          |

| <b>Categoria</b>       | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>                           | <b>Contexto / observação</b>                                                                 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                        | Assessment, Development and Evaluation            | avaliar certeza da evidência e força de recomendações.                                       |
| Pesquisa e estatística | <b>AIM</b>             | Autism Intervention Meta-analysis                 | Nome do Project AIM, projeto de meta-análise de intervenções em autismo.                     |
| Pesquisa e estatística | <b>GWAS</b>            | Genome-Wide Association Study                     | Estudo de associação genômica ampla.                                                         |
| Pesquisa e estatística | <b>CNV</b>             | Copy Number Variant                               | Variante no número de cópias: deleção ou duplicação de segmentos de DNA.                     |
| Pesquisa e estatística | <b>EEG</b>             | Eletroencefalografia / eletroencefalograma        | Método de registro da atividade elétrica cerebral.                                           |
| Pesquisa e estatística | <b>DNA</b>             | Deoxyribonucleic Acid / ácido desoxirribonucleico | Molécula que armazena informação genética.                                                   |
| Pesquisa e estatística | <b>IA</b>              | Inteligência Artificial                           | Área computacional utilizada em pesquisas de classificação, predição e apoio à análise.      |
| Pesquisa e estatística | <b>AI</b>              | Artificial Intelligence                           | Nome em inglês para Inteligência Artificial.                                                 |
| Pesquisa e estatística | <b>ML</b>              | Machine Learning                                  | Aprendizado de máquina.                                                                      |
| Pesquisa e estatística | <b>iPSC</b>            | induced Pluripotent Stem Cells                    | Células-tronco pluripotentes induzidas, usadas em pesquisa de modelos celulares.             |
| Pesquisa e estatística | <b>PMID</b>            | PubMed Identifier                                 | Identificador numérico de um registro na base PubMed.                                        |
| Pesquisa e estatística | <b>PMCID</b>           | PubMed Central Identifier                         | Identificador de artigo em texto completo no PubMed Central.                                 |
| Pesquisa e estatística | <b>DOI</b>             | Digital Object Identifier                         | Identificador digital persistente de publicação científica.                                  |
| Órgãos e instituições  | <b>OMS</b>             | Organização Mundial da Saúde                      | Agência especializada das Nações Unidas para saúde.                                          |
| Órgãos e instituições  | <b>WHO</b>             | World Health Organization                         | Nome em inglês da Organização Mundial da Saúde.                                              |
| Órgãos e instituições  | <b>OPAS</b>            | Organização Pan-Americana da Saúde                | Escritório regional da OMS para as Américas.                                                 |
| Órgãos e instituições  | <b>CDC</b>             | Centers for Disease Control and Prevention        | Agência federal de saúde pública dos Estados Unidos.                                         |
| Órgãos e instituições  | <b>AAP</b>             | American Academy of Pediatrics                    | Academia Americana de Pediatria.                                                             |
| Órgãos e instituições  | <b>NICE</b>            | National Institute for Health and Care Excellence | Instituto do Reino Unido que publica diretrizes clínicas e de saúde.                         |
| Órgãos e instituições  | <b>FDA</b>             | United States Food and Drug Administration        | Agência reguladora de alimentos, medicamentos e outros produtos de saúde nos Estados Unidos. |
| Órgãos e instituições  | <b>ANS</b>             | Agência Nacional de Saúde Suplementar             | Órgão regulador dos planos privados de assistência à saúde no Brasil.                        |

| <b>Categoria</b>                          | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>                                                | <b>Contexto / observação</b>                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgãos e instituições                     | <b>INEP</b>            | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Autarquia federal brasileira ligada ao Ministério da Educação.                                       |
| Órgãos e instituições                     | <b>MEC</b>             | Ministério da Educação                                                 | Órgão do Poder Executivo federal brasileiro responsável pela política nacional de educação.          |
| Órgãos e instituições                     | <b>IBGE</b>            | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística                        | Instituto responsável por estatísticas e censos oficiais no Brasil.                                  |
| Órgãos e instituições                     | <b>SUS</b>             | Sistema Único de Saúde                                                 | Sistema público de saúde brasileiro.                                                                 |
| Órgãos e instituições                     | <b>CER</b>             | Centro Especializado em Reabilitação                                   | Ponto de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.                                       |
| Órgãos e instituições                     | <b>CAPS</b>            | Centro de Atenção Psicossocial                                         | Serviço comunitário especializado da Rede de Atenção Psicossocial.                                   |
| Órgãos e instituições                     | <b>CAPSi</b>           | Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil                          | Modalidade de CAPS voltada prioritariamente a crianças e adolescentes.                               |
| Órgãos e instituições                     | <b>RAS</b>             | Rede de Atenção à Saúde                                                | Organização integrada de ações e serviços de saúde.                                                  |
| Órgãos e instituições                     | <b>ASHA</b>            | American Speech-Language-Hearing Association                           | Associação profissional norte-americana das áreas de fala, linguagem e audição.                      |
| Órgãos e instituições                     | <b>NCBI</b>            | National Center for Biotechnology Information                          | Centro que mantém bases biomédicas como PubMed e PubMed Central.                                     |
| Órgãos e instituições                     | <b>ADDM</b>            | Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network               | Rede de monitoramento de autismo e deficiências do desenvolvimento coordenada pelo CDC.              |
| Órgãos e instituições                     | <b>RN</b>              | Resolução Normativa                                                    | Tipo de ato normativo; no dossiê aparece especialmente em normas da ANS.                             |
| Periódicos e publicações                  | <b>BMJ</b>             | BMJ (historicamente British Medical Journal)                           | Periódico médico internacional; atualmente utiliza oficialmente a marca BMJ.                         |
| Periódicos e publicações                  | <b>JAMA</b>            | Journal of the American Medical Association                            | Família de periódicos médicos liderada pelo periódico JAMA.                                          |
| Periódicos e publicações                  | <b>MMWR</b>            | Morbidity and Mortality Weekly Report                                  | Publicação epidemiológica do CDC.                                                                    |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>CBD</b>             | Cannabidiol / canabidiol                                               | Canabinoide não intoxicante estudado em diferentes condições; evidência para TEA permanece limitada. |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>THC</b>             | Delta-9-tetrahydrocannabinol                                           | Principal canabinoide intoxicante da cannabis.                                                       |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>FMT</b>             | Fecal Microbiota Transplantation                                       | Transplante de microbiota fecal.                                                                     |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>GFCF</b>            | Gluten-Free, Casein-Free                                               | Dieta sem glúten e sem caseína.                                                                      |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>NAC</b>             | N-acetylcysteine / N-acetilcisteína                                    | Fármaco/suplemento estudado experimentalmente                                                        |

| <b>Categoria</b>                          | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>                                                                        | <b>Contexto / observação</b>                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                        |                                                                                                | para alguns desfechos.                                                                                                              |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>tDCS</b>            | transcranial Direct Current Stimulation                                                        | Estimulação transcraniana por corrente contínua.                                                                                    |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>TMS</b>             | Transcranial Magnetic Stimulation                                                              | Estimulação magnética transcraniana.                                                                                                |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>EDTA</b>            | Ethylenediaminetetraacetic Acid / ácido etilenodiamino tetra-acético                           | Agente quelante utilizado em indicações médicas específicas; não é tratamento para TEA.                                             |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>Na2EDTA</b>         | Disodium EDTA / edetato dissódico                                                              | Sal dissódico do EDTA; uso inadequado em quelação pode causar toxicidade grave.                                                     |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>MMS</b>             | Miracle Mineral Solution / Master Mineral Solution                                             | Nome comercial informal de produtos à base de clorito/dióxido de cloro; não é tratamento aprovado para autismo e pode ser perigoso. |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>GI</b>              | Gastrointestinal                                                                               | Abreviação usada para manifestações do trato gastrointestinal.                                                                      |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>PM2.5</b>           | Particulate Matter $\leq 2.5$ micrometers / material particulado fino de até 2,5 $\mu\text{m}$ | Indicador de poluição atmosférica estudado em epidemiologia ambiental.                                                              |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>NOx</b>             | Nitrogen Oxides / óxidos de nitrogênio                                                         | Grupo de poluentes atmosféricos estudado em epidemiologia ambiental.                                                                |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>MMR</b>             | Measles, Mumps and Rubella vaccine                                                             | Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola, conhecida no Brasil como tríplice viral.                                                  |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>B6</b>              | Vitamina B6                                                                                    | Grupo de compostos que inclui piridoxina, piridoxal e piridoxamina.                                                                 |
| Substâncias e tratamentos em investigação | <b>B12</b>             | Vitamina B12                                                                                   | Grupo de cobalaminas essenciais ao metabolismo humano.                                                                              |
| Genética e biologia molecular             | <b>SHANK3</b>          | SH3 and Multiple Ankyrin Repeat Domains 3                                                      | Símbolo oficial de gene associado, em determinadas variantes, a condições do neurodesenvolvimento.                                  |
| Genética e biologia molecular             | <b>CHD8</b>            | Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 8                                                    | Símbolo oficial de gene relacionado à regulação da cromatina.                                                                       |
| Genética e biologia molecular             | <b>SCN2A</b>           | Sodium Voltage-Gated Channel Alpha Subunit 2                                                   | Símbolo oficial de gene que codifica subunidade de canal de sódio.                                                                  |
| Genética e biologia molecular             | <b>ADNP</b>            | Activity-Dependent Neuroprotector Homeobox                                                     | Símbolo oficial de gene associado a síndrome do neurodesenvolvimento.                                                               |
| Genética e biologia molecular             | <b>FOXP1</b>           | Forkhead Box P1                                                                                | Símbolo oficial de gene regulador de transcrição.                                                                                   |
| Genética e biologia molecular             | <b>SYNGAP1</b>         | Synaptic Ras GTPase Activating Protein 1                                                       | Símbolo oficial de gene relacionado à função sináptica.                                                                             |
| Genética e biologia molecular             | <b>PTEN</b>            | Phosphatase and Tensin Homolog                                                                 | Símbolo oficial de gene supressor tumoral e                                                                                         |

| <b>Categoria</b>              | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>                                  | <b>Contexto / observação</b>                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                          | regulador de sinalização celular.                                                                                       |
| Genética e biologia molecular | <b>MECP2</b>           | Methyl-CpG Binding Protein 2                             | Símbolo oficial de gene associado, entre outras condições, à síndrome de Rett.                                          |
| Genética e biologia molecular | <b>FRAA</b>            | Folate Receptor Alpha Autoantibody/Autoantibodies        | Autoanticorpo(s) contra o receptor alfa de folato, objeto de investigação em estudos selecionados.                      |
| Condições coexistentes        | <b>TDAA</b>            | Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade      | Condição do neurodesenvolvimento que pode coexistir com TEA e requer avaliação própria.                                 |
| Órgãos e instituições         | <b>UBS</b>             | Unidade Básica de Saúde                                  | Serviço da Atenção Primária à Saúde e porta de entrada importante do SUS.                                               |
| Países e contexto geográfico  | <b>EUA</b>             | Estados Unidos da América                                | Abreviação utilizada ao mencionar estudos, agências e dados norte-americanos.                                           |
| Educação e direitos           | <b>ECA</b>             | Estatuto da Criança e do Adolescente                     | Lei nº 8.069/1990; estabelece proteção integral e prioridade para crianças e adolescentes.                              |
| Assistência social            | <b>LOAS</b>            | Lei Orgânica da Assistência Social                       | Lei nº 8.742/1993; organiza a assistência social e regulamenta o BPC.                                                   |
| Assistência social            | <b>BPC</b>             | Benefício de Prestação Continuada                        | Benefício assistencial previsto na LOAS para pessoa idosa ou pessoa com deficiência que cumpra os requisitos legais.    |
| Assistência social            | <b>SUAS</b>            | Sistema Único de Assistência Social                      | Sistema público que organiza serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.                          |
| Assistência social            | <b>CRAS</b>            | Centro de Referência de Assistência Social               | Unidade pública da proteção social básica e referência para CadÚnico e orientação socioassistencial.                    |
| Assistência social            | <b>CREAS</b>           | Centro de Referência Especializado de Assistência Social | Unidade da proteção social especial para situações de violação de direitos e risco social, conforme atribuições locais. |
| Assistência social            | <b>CadÚnico</b>        | Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal | Base utilizada para identificar e caracterizar famílias de baixa renda e                                                |

| <b>Categoria</b>      | <b>Sigla / símbolo</b> | <b>Nome por extenso</b>             | <b>Contexto / observação</b>                                                                              |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                                     | requisito administrativo de diferentes políticas, inclusive BPC.                                          |
| Órgãos e instituições | INSS                   | Instituto Nacional do Seguro Social | Órgão responsável pela operacionalização administrativa do BPC e de benefícios previdenciários.           |
| Órgãos e instituições | MP                     | Ministério Público                  | Instituição constitucional de defesa da ordem jurídica e de direitos sociais e individuais indisponíveis. |

## Anexo G - Matriz de referências essenciais

| <b>ID</b> | <b>Referência/fonte</b>                                                                                                              | <b>Uso no dossiê</b>                                            | <b>Identificador/link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01       | WHO. Autism. Fact sheet, 17 Sep 2025.                                                                                                | Definição, prevalência mundial e princípios de cuidado.         | <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders">https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders</a>                                                                                                                                     |
| R02       | Hyman SL, Levy SE, Myers SM. Identification, Evaluation, and Management of Children With ASD. Pediatrics. 2020; reaffirmed Oct 2025. | AAP: rastreamento, avaliação, genética, condições coexistentes. | <a href="https://publications.aap.org/pediatrics/article/145/1/e20193447/36917/">https://publications.aap.org/pediatrics/article/145/1/e20193447/36917/</a>                                                                                                                                             |
| R03       | WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements.                                                                       | Classificação internacional e especificadores.                  | <a href="https://icd.who.int/">https://icd.who.int/</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R04       | IBGE. Censo 2022 contou 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. 2025.                                           | Prevalência informada no Brasil.                                | <a href="https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22700-censo-2022-contou-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil.html">https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22700-censo-2022-contou-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil.html</a> |
| R05       | CDC. ADDM Network, prevalence among 8-year-olds, 2022 surveillance.                                                                  | Epidemiologia dos EUA; 1 em 31 nos sítios ADDM.                 | <a href="https://www.cdc.gov/autism/">https://www.cdc.gov/autism/</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| R06       | NICE CG170. Autism spectrum disorder in under 19s: support and management.                                                           | Intervenções, comportamento, práticas não recomendadas.         | <a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg170/chapter/Recommendations">https://www.nice.org.uk/guidance/cg170/chapter/Recommendations</a>                                                                                                                                                             |
| R07       | NICE CG142. Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management.                                                            | Adultos, emprego apoiado e práticas não recomendadas.           | <a href="https://www.nice.org.uk/guidance/cg142/chapter/Recommendations">https://www.nice.org.uk/guidance/cg142/chapter/Recommendations</a>                                                                                                                                                             |
| R08       | Sukhareva GE. Historical clinical descriptions, 1925-1927.                                                                           | Marco pré-Kanner.                                               | PubMed historical reviews                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R09       | Kanner L. Autistic Disturbances of Affective Contact. 1943.                                                                          | Descrição clínica clássica de 11 crianças.                      | Historical archive                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R10       | Asperger H. Die "Autistischen Psychopathen" im Kindesalter. 1944.                                                                    | Marco histórico; exige contextualização ética/histórica.        | Historical literature                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R11       | Sheffer E / Czech H historical scholarship on Asperger and Nazi Vienna.                                                              | Contextualização histórica crítica.                             | PMID 29713442                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R12       | Folstein S, Rutter M. Infantile autism: a genetic study of 21 twin pairs. 1977.                                                      | Marco da genética de gêmeos.                                    | PMID 562353                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R13       | Wing L, Gould J. Severe impairments of social interaction... 1979.                                                                   | Continuum/espectro.                                             | PMID 155684                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R14       | WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety. Vaccines and autism statement, 2025.                                                | Ausência de evidência causal.                                   | <a href="https://www.who.int/news/item/11-12-2025-statement-gacvs-vaccines-autism">https://www.who.int/news/item/11-12-2025-statement-gacvs-vaccines-autism</a>                                                                                                                                         |

| ID  | Referência/fonte                                                                                                                                         | Uso no dossiê                                            | Identificador/link               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| R15 | Wakefield et al. 1998 - retracted by The Lancet 2010.                                                                                                    | Exemplo histórico de evidência inválida e desinformação. | BMJ/Lancet retraction records    |
| R16 | Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith U. Does the autistic child have a theory of mind? 1985.                                                                  | Marco cognitivo; não explicação total.                   | PMID 2934210                     |
| R17 | Lord C et al. ADOS/ADI-R development papers.                                                                                                             | Padronização de avaliação.                               | PMIDs 2745388, 7814313, 11055457 |
| R18 | Bai D et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. JAMA Psychiatry. 2019.                                  | Herdabilidade populacional ~80,8%.                       | PMID 31314057                    |
| R19 | Tick B et al. Heritability of autism spectrum disorders: a meta-analysis of twin studies. 2016.                                                          | Herdabilidade elevada em estudos de gêmeos.              | PMCID PMC4996332                 |
| R20 | Satterstrom FK et al. Large-Scale Exome Sequencing Study Implicates Both Developmental and Functional Changes in the Neurobiology of Autism. Cell. 2020. | 102 genes de risco.                                      | PMID 31981491                    |
| R21 | Fu JM et al. Rare coding variation provides insight into the genetic architecture... Nat Genet. 2022.                                                    | 72 genes rigorosos, 185 em limiar mais amplo.            | PMID 35982160                    |
| R22 | Grove J et al. Identification of common genetic risk variants for autism spectrum disorder. Nat Genet. 2019.                                             | GWAS e variantes comuns.                                 | DOI 10.1038/s41588-019-0344-8    |
| R23 | Global Burden of Disease 2021 autism analysis. Lancet Psychiatry. 2025.                                                                                  | Carga/prevalência global.                                | PMID 39709974                    |
| R24 | Lord C et al. The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism. Lancet. 2022.                                                 | Cuidado ao longo da vida, heterogeneidade e prioridades. | PMID 34883054                    |
| R25 | Lovaas OI. Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning... 1987.                                                             | Marco histórico EIBI; limitações metodológicas/éticas.   | PMID 3571656                     |
| R26 | Dawson G et al. Randomized, controlled trial of ESDM. Pediatrics. 2010.                                                                                  | ESDM.                                                    | PMID 19948568                    |
| R27 | Green J et al. PACT RCT. Lancet. 2010.                                                                                                                   | Intervenção mediada por cuidadores.                      | PMID 20494434                    |
| R28 | Pickles A et al. PACT follow-up. Lancet. 2016.                                                                                                           | Persistência de alguns efeitos.                          | PMID 27793431                    |
| R29 | Schreibman L et al. Naturalistic Developmental Behavioral Interventions. J Autism Dev Disord. 2015.                                                      | Definição de NDBI.                                       | PMID 25737021                    |
| R30 | Sandbank M et al. Project AIM meta-analyses, initial and update.                                                                                         | Intervenções precoces e risco de viés.                   | PMID 37963634                    |
| R31 | Bottema-Beutel K et al. Adverse event reporting in nonpharmacological autism intervention studies.                                                       | Subnotificação de eventos adversos.                      | PMID 33076682                    |
| R32 | Sharma S et al. CBT for anxiety in autistic youth: meta-analysis.                                                                                        | TCC adaptada para ansiedade.                             | PMID 34598734                    |
| R33 | Geretsegger M et al. Music therapy for autistic people. Cochrane. 2022.                                                                                  | Musicoterapia.                                           | Cochrane CD004381                |
| R34 | Cochrane. Atypical antipsychotics for irritability in autism, 2025.                                                                                      | Risperidona/aripiprazol.                                 | Cochrane CD014965                |
| R35 | Nogueira et al. Melatonin for sleep in ASD: meta-analysis. 2023.                                                                                         | Sono.                                                    | PMID 36584862                    |

| ID  | Referência/fonte                                                                             | Uso no dossiê                                                       | Identificador/link                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R36 | ASHA Practice Portal: Autism.                                                                | Comunicação, fala e AAC.                                            | <a href="https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/autism/">https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/autism/</a>                                                                                                                                                                         |
| R37 | Systematic review/meta-analysis of gut microbiota-based therapy. 2025.                       | 15 RCTs; efeito agregado pequeno.                                   | PMID 41037658                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R38 | Microbiota-based therapies as novel targets for ASD. 2025.                                   | Síntese de probióticos/FMT e outras estratégias.                    | PMID 40348275                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R39 | Pereira DA et al. Efficacy and Safety of Cannabinoids for ASD. 2025.                         | 7 estudos, 494 pacientes; achados preliminares.                     | PMID 40248548                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R40 | Riera R et al. Cannabis derivatives/analogs for ASD - systematic review of RCTs. 2025.       | Certeza muito baixa/baixa.                                          | PMID 40605143                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R41 | Frye RE et al. Folinic acid improves verbal communication... 2016.                           | Pequeno RCT e hipótese FRAA.                                        | PMID 27752075                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R42 | Panda PK et al. Retraction Note... Eur J Pediatr. 2026.                                      | Retratação de RCT de folinato publicado em 2024.                    | PMID 41606385                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R43 | Wang R et al. Sulforaphane systematic review/meta-analysis. 2025.                            | 6 RCTs; efeitos pequenos.                                           | PMID 40458076                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R44 | Long J et al. Sulforaphane meta-analysis. 2025.                                              | 6 ensaios, 333 participantes.                                       | PMID 41275316                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R45 | Ur Rehman A et al. Bumetanide systematic review/meta-analysis. 2026.                         | 9 estudos, 952; curto prazo, baixa certeza, eventos adversos.       | PMID 41968733                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R46 | US FDA. Consumer Alert on Regenerative Medicine Products Including Stem Cells and Exosomes.  | Nenhum produto regenerativo aprovado para autismo.                  | <a href="https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/consumers-biologics/consumer-alert-regenerative-medicine-products-including-stem-cells-and-exosomes">https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/consumers-biologics/consumer-alert-regenerative-medicine-products-including-stem-cells-and-exosomes</a> |
| R47 | Williams K et al. Intravenous secretin for ASD. Cochrane. 2022.                              | 16 RCTs, >900 crianças, sem benefício.                              | Cochrane CD003495                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R48 | James S et al. Chelation for ASD. Cochrane. 2015.                                            | Sem evidência de benefício; riscos.                                 | PMID 26114777                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R49 | CDC MMWR. Deaths Associated with Hypocalcemia from Chelation Therapy, 2003-2005.             | Óbito de criança autista durante quelação com Na2EDTA.              | <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5508a3.htm">https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5508a3.htm</a>                                                                                                                                                                                     |
| R50 | US FDA. Warnings/testimony on Miracle Mineral Solution/chlorine dioxide.                     | Toxicidade e alegações fraudulentas, incluindo autismo.             | <a href="https://www.fda.gov/">https://www.fda.gov/</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R51 | Systematic reviews of diet/GFCF and ketogenic approaches.                                    | Evidência pequena/heterogênea; diretrizes não recomendam para core. | See NICE R06/R07                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R52 | Cook J et al. Camouflaging in autism: systematic review. 2021.                               | 29 estudos.                                                         | PMID 34563942                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R53 | Cruz S et al. Bias towards males in autism diagnosis: systematic review/meta-analysis. 2025. | Fenótipo e viés diagnóstico.                                        | PMID 38285291                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R54 | Autistic Traits and Camouflaging: Meta-Analysis. 2026.                                       | 50 estudos, N=16.895.                                               | PMID 42028799                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R55 | Meta-analytic review of camouflaging measurement. Sci Rep. 2025.                             | Diferenças por método/sexo.                                         | PMID 40594613                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R56 | Tsou YT et al. School-Based Interventions for Social Inclusion. 2026.                        | 56 estudos; inclusão exige mudança contextual.                      | PMID 41868250                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R57 | Peer-Mediated Social Skills Interventions in Primary School. 2024.                           | 24 estudos; eficácia com pouco follow-up.                           | PMID 39467895                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R58 | Interventions for students with autism in inclusive settings: meta-analysis.                 | Apoios visuais, função, pares e professores.                        | PMID 30869925                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ID  | Referência/fonte                                                                                                                                | Uso no dossiê                                                                     | Identificador/link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R59 | Prevalence of Victimisation in Autistic Individuals: meta-analysis.                                                                             | Risco elevado e heterogêneo.                                                      | PMID 35524162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R60 | School absenteeism in autistic children/adolescents: scoping review.                                                                            | 42 estudos; saúde mental, bullying e suporte escolar.                             | PMID 38159071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R61 | INEP. O que é o AEE? Atualizado 31 Aug 2026.                                                                                                    | Definição oficial de AEE e TEA.                                                   | <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/censo-escolar/educacao-especial/o-que-e-o-atendimento">https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/censo-escolar/educacao-especial/o-que-e-o-atendimento</a>                                                                                           |
| R62 | Motamed M et al. Sexual health, knowledge and behavior in ASD: systematic review. 2025.                                                         | Sexualidade, relações e vitimização.                                              | PMID 40264093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R63 | White LM et al. Transitioning on from Secondary School for Autistic Students. 2025.                                                             | Transição pós-escola.                                                             | PMID 40933688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R64 | Smith IC et al. Interventions for autistic adults: meta-analysis. 2026.                                                                         | 35 estudos, N=1.631.                                                              | PMID 41926193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R65 | Dickinson A et al. Aging in autism: systematic review. 2026.                                                                                    | Cognição, cérebro e saúde física no envelhecimento.                               | PMID 42302955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R66 | Comparison of interventions for mental health of parents of autistic children: network meta-analysis. 2024.                                     | 69 estudos, 4.213 pais.                                                           | PMID 39489145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R67 | Peng Q et al. Mindfulness-based interventions for autistic children and parents. 2025.                                                          | 12 RCTs, 643 participantes.                                                       | PMID 40657585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R68 | WHO. Caregiver Skills Training package.                                                                                                         | Programa familiar de comunicação, engajamento, comportamento e vida diária.       | <a href="https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/treatment-care/who-caregivers-skills-training-for-families-of-children-with-developmental-delays-and-disorders">https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/treatment-care/who-caregivers-skills-training-for-families-of-children-with-developmental-delays-and-disorders</a> |
| R69 | WHO. Caregiver well-being guides. 7 May 2026 / OPAS Portuguese edition Jun 2026.                                                                | Bem-estar de cuidadores.                                                          | <a href="https://www.who.int/publications/i/item/9789240120983">https://www.who.int/publications/i/item/9789240120983</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| R70 | Yu X, Xu X. Recommendations from Lancet Commission. 2022.                                                                                       | Síntese de heterogeneidade e “profound autism” administrativo.                    | PMID 37724192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R71 | Eicher T et al. Genomic, Transcriptomic, and Regulomic Analyses Do Not Support Profound Autism as a Distinct Biological Category. bioRxiv 2026. | Preprint; cautela contra subtipo biológico.                                       | PMID 42282515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R72 | Santomauro DF et al. Global burden of suicide mortality among people on the autism spectrum. 2024.                                              | RR agregado de suicídio e lacunas geográficas.                                    | PMID 39197224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R73 | Suicidality in autistic youth: systematic review/meta-analysis.                                                                                 | Prevalência heterogênea e fatores de risco.                                       | PMID 35290800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R74 | Brasil. Lei 12.764/2012, atualizada.                                                                                                            | Política Nacional e direitos da pessoa com TEA.                                   | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm</a>                                                                                                                                                                                                   |
| R75 | Brasil. Lei 14.626/2023.                                                                                                                        | Atendimento prioritário, incluindo pessoas com TEA.                               | <a href="https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114626.htm">https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114626.htm</a>                                                                                                                                                                                                           |
| R76 | Brasil. Lei 14.880/2024.                                                                                                                        | Atenção precoce na educação especial.                                             | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114880.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114880.htm</a>                                                                                                                                                                                                   |
| R77 | Brasil. Lei 15.131/2025.                                                                                                                        | Nutrição adequada e terapia nutricional por profissional habilitado e protocolos. | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/115131.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/115131.htm</a>                                                                                                                                                                                                   |
| R78 | Brasil. Lei 15.256/2025.                                                                                                                        | Incentivo à investigação diagnóstica em adultos e idosos.                         | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/115256.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/115256.htm</a>                                                                                                                                                                                                   |

| ID  | Referência/fonte                                                                                                          | Uso no dossiê                                                                                                        | Identificador/link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R79 | Ministério da Saúde. TEA na Atenção Especializada.                                                                        | UBS, CER, CAPS/CAPSi e rede.                                                                                         | <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/atencao-especializada">https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/atencao-especializada</a>                                                                                                                                                                                             |
| R80 | Ministério da Saúde. Consulta Pública nº 03/2026 - Guia de Cuidado Integral às Pessoas com TEA.                           | Status encerrada; ciclo de vida e RAS.                                                                               | <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/consulta-publica-revisao-e-atualizacao-do-guia-de-cuidado-integral-as-pessoas-com-tea">https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/consulta-publica-revisao-e-atualizacao-do-guia-de-cuidado-integral-as-pessoas-com-tea</a> |
| R81 | Ministério da Saúde. Caderno da Consulta Pública do Guia de Cuidado Integral.                                             | Abordagem centrada na pessoa, interdisciplinar e longitudinal.                                                       | Gov.br, 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R82 | ANS. RN 539/2022.                                                                                                         | Cobertura de método/técnica indicada para TGD/TEA nos procedimentos abrangidos.                                      | <a href="https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0539_24_06_2022.html">https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0539_24_06_2022.html</a>                                                                                                                                                                                                                     |
| R83 | ANS. RN 541/2022.                                                                                                         | Fim dos limites de sessões de psicologia, fono, TO e fisioterapia em planos regulamentados aplicáveis.               | <a href="https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0541_13_07_2022.html">https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0541_13_07_2022.html</a>                                                                                                                                                                                                                     |
| R84 | ANS. Notícias e Parecer Técnico 39/2024 sobre métodos no tratamento do TEA.                                               | Orientação de cobertura atualizada.                                                                                  | <a href="https://www.gov.br/ans/">https://www.gov.br/ans/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R85 | Systematic review/meta-analysis of eye-tracking + machine learning for autism. 2026.                                      | Acurácia agregada promissora, mas validação externa limitada.                                                        | Recent PubMed 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R86 | Systematic reviews of EEG/fNIRS + machine learning in autism. 2026.                                                       | Biomarcadores experimentais e desafios de generalização.                                                             | Recent PubMed 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R87 | Reviews of AI/neuroimaging for ASD diagnosis. 2025-2026.                                                                  | Ferramentas de apoio; limitações de dataset, viés e interpretabilidade.                                              | Recent PubMed 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R88 | Brasil. Decreto nº 8.368/2014.                                                                                            | Regulamenta a Lei nº 12.764/2012; saúde no SUS, proteção social e educação inclusiva/acompanhante especializado.     | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8368.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8368.htm</a>                                                                                                                                                                                                                     |
| R89 | Brasil. Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, texto atualizado.                                       | Proteção integral, saúde, dignidade, educação, prevenção de violência, medidas protetivas e Conselho Tutelar.        | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R90 | Brasil. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.                                        | Educação inclusiva, acessibilidade, profissionais de apoio e vedação de cobrança adicional em instituições privadas. | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| R91 | Brasil. Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social, texto atualizado.                                         | Proteção social, Benefício de Prestação Continuada e Auxílio-Inclusão.                                               | <a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R92 | Governo Federal / INSS. Solicitar Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS), atualizado em 12 ago. 2026. | Requisitos administrativos, CadÚnico e canais oficiais para requerimento do BPC.                                     | <a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-beneficio-assistencial-a-pessoa-com-deficiencia">https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-beneficio-assistencial-a-pessoa-com-deficiencia</a>                                                                                                                                                                                   |

| ID  | Referência/fonte                                                                                         | Uso no dossiê                                     | Identificador/link                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R93 | Governo Federal / INSS. Solicitar Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência, atualizado em 12 ago. 2026. | Requisitos e canais oficiais do Auxílio-Inclusão. | <a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-auxilio-inclusao-a-pessoa-com-deficiencia">https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-auxilio-inclusao-a-pessoa-com-deficiencia</a> |

## Anexo H - Protocolo de atualização do acervo

Para manter o material confiável, recomenda-se revisão semestral de diretrizes e anual da literatura, com busca estruturada em PubMed, Cochrane, WHO/OMS, NICE, AAP, CDC, Ministério da Saúde, ANS, MEC/INEP, Planalto e IBGE. Toda atualização deve registrar a data da busca, novos estudos, estudos retratados/corrigidos e mudanças de recomendação.

| Etapa            | Ação                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Busca         | Pesquisar últimos 12 meses + alertas por termos “autism systematic review”, “randomized trial”, “guideline”, “retraction”. |
| 2. Triagem       | Priorizar revisões sistemáticas, RCTs, grandes coortes e documentos oficiais.                                              |
| 3. Verificação   | Checar PubMed para retraction/correction e conflito de interesse.                                                          |
| 4. Extração      | Atualizar amostra, efeito, limitações e população.                                                                         |
| 5. Classificação | Revisar selo de evidência por objetivo específico.                                                                         |
| 6. Comunicação   | Produzir resumo para famílias sem perder incerteza científica.                                                             |
| 7. Arquivamento  | Manter versão, data e histórico de alterações.                                                                             |

## Conclusão editorial

O melhor acervo sobre autismo não é o que contém mais promessas; é o que torna a incerteza visível, diferencia associação de causa, separa intervenção de cura, atualiza evidências negativas, valoriza a voz das pessoas autistas e oferece às famílias ferramentas para decidir com segurança. Este dossiê deve ser entendido como documento vivo: ciência, políticas públicas e direitos continuam mudando.

**Versão 1.2 cumulativa - fechada em 21 de setembro de 2026, com glossário ampliado, siglas por extenso e capítulo jurídico expandido sobre a Lei Berenice Piana, educação, saúde, assistência social e proteção do ECA. Próxima revisão recomendada: março de 2027, ou antes se houver nova diretriz nacional do Ministério da Saúde, atualização importante da American Academy of Pediatrics (AAP), National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ou Organização Mundial da Saúde (OMS), ou alteração legislativa relevante.**